AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

ENDOCRINOLOGÍA

Metabolismo

25 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Patología Tiroidea Funcional: Hipotiroidismo y Tiroiditis

★☆☆ 1.1. Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo GES 3
★★★ 1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina GES 4
★☆☆ 1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas 6
★★★ 1.4. Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito GES 7
★★☆ 1.5. Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) 8

02 Bloque 2 · Tirotoxicosis, Bocio, Nódulo y Cáncer de Tiroides

★★☆ 7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos 9
★★☆ 7.7. Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía 11
★☆☆ 7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas 12
★★★ 7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF GES 14
★☆☆ 7.10. Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico GES 16

03 Bloque 3 · Corteza y Médula Suprarrenal: Cushing, Addison, Conn y Feocromocitoma

★★☆ 7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico 17
★☆☆ 7.12. Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria 18
★★★ 7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario 19
★★★ 7.14. Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria 20
★★☆ 7.15. Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio 21

04 Bloque 4 · Metabolismo Mineral, Calcio, Paratiroides y Hueso

★★★ 7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico 22
★★★ 7.17. Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia 24
★☆☆ 7.18. Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento 25
★☆☆ 7.19. Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo 26

05 Bloque 5 · Hipófisis, Hipotálamo, Neuroendocrinología y MEN

★★★ 7.20. Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria 27
★★☆ 7.21. Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica 28
★★★ 7.22. Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo 29
★★☆ 7.23. Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo 30
★★☆ 7.24. Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) 31
★☆☆ 7.25. Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica 32

Números que tienes que saber 33
Fármacos de primera línea 36
GES de la especialidad 37
Plan de repaso de 7 días 38
Índice por prioridad ★ 39

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

1.1 Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.03.4.003 TSH, T4, T3 — Interpreta y emplea

También: T4 libre

LO QUE TE PREGUNTAN

- La TSH es la prueba inicial más sensible y costo-efectiva para evaluar la función tiroidea en cualquier nivel de atención.
- En hipotiroidismo primario la TSH está alta y la T4 libre baja; en hipotiroidismo subclínico la TSH está alta pero la T4 libre es NORMAL.
- El hipotiroidismo central se caracteriza por T4 libre baja con TSH baja o paradójicamente "normal" (inapropiada para el nivel de T4).
- **¡Alerta!**: Nunca iniciar levotiroxina en un hipotiroidismo central sin haber descartado y tratado previamente una insuficiencia suprarrenal.
- El Síndrome del Eutiroideo Enfermo cursa con T3 marcadamente baja y T3 reversa elevada en pacientes críticos de UCI.
- Está contraindicado administrar levotiroxina o T3 en el síndrome del eutiroideo enfermo; la alteración se resuelve al sanar la enfermedad de base.

ALGORITMO · INTERPRETACIÓN INICIAL DEL PERFIL TIROIDEO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

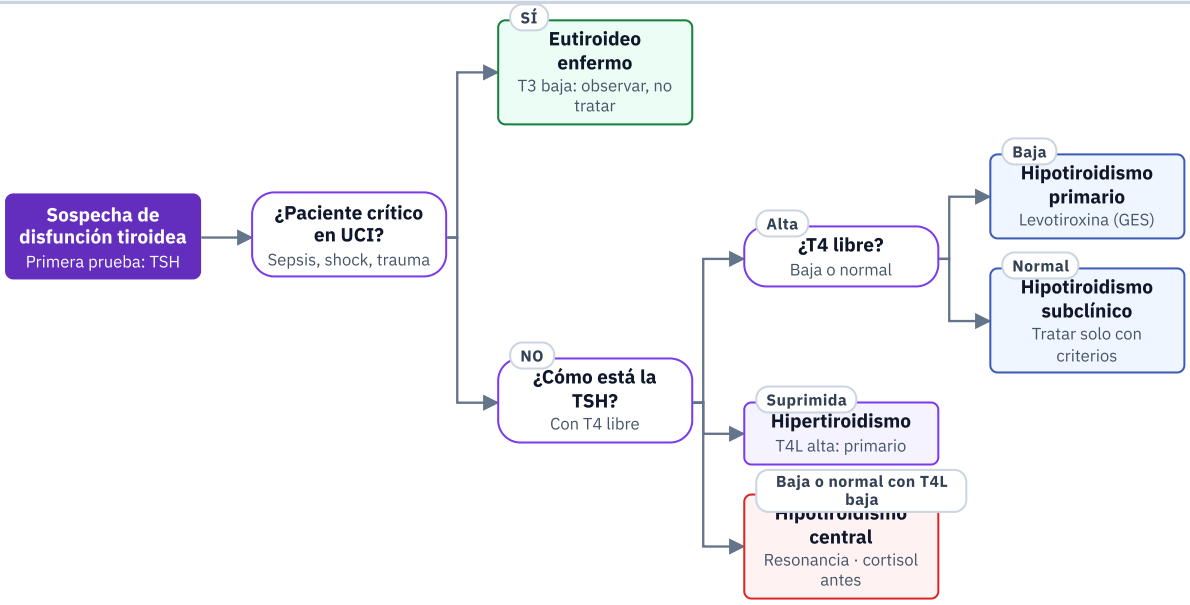


TABLA 1.1 · PATRONES ANALÍTICOS CLÁSICOS EN PRUEBAS DE FUNCIÓN TIROIDEA

DIAGNÓSTICO ENDOCRINOLÓGICO	TSH PLASMÁTICA	T4 LIBRE (T4L)	T3 TOTAL / LIBRE	CONDUCTA CLÍNICA EUNACOM
Hipotiroidismo Primario	ELEVADA (> 4.5 mIU/L)	DISMINUIDA (< 0.8 ng/dL)	Normal o Disminuida	Iniciar Levotiroxina (1.6 mcg/kg/d) GES
Hipotiroidismo Subclínico	ELEVADA (> 4.5 mIU/L)	NORMAL	Normal	Tratar si TSH ≥ 10, síntomas, anti-TPO(+) o embarazo
Hipotiroidismo Central	Baja o "Normal" inapropiada	DISMINUIDA	Disminuida	RMN hipófisis; descartar Addison antes de hormona
Hipertiroidismo Primario	SUPRIMIDA (< 0.1 mIU/L)	ELEVADA	Elevada	Iniciar Tiamazol / Propranolol + Anticuerpos TRAb
Hipertiroidismo Subclínico	SUPRIMIDA (< 0.4 mIU/L)	NORMAL	Normal	Observar; tratar si FA, osteoporosis o TSH < 0.1
Síndrome Eutiroideo Enfermo	Normal o Levemente Baja	Normal o Baja (grave)	DISMINUIDA (T3 reversa alta)	OBSERVACIÓN en UCI; ¡Prohibido dar levotiroxina!

REGLA DE ORO **La TSH es la primera prueba** — Ante cualquier sospecha tiroidea

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **1–6** (pág. 15) · solucionario pág. 29.

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

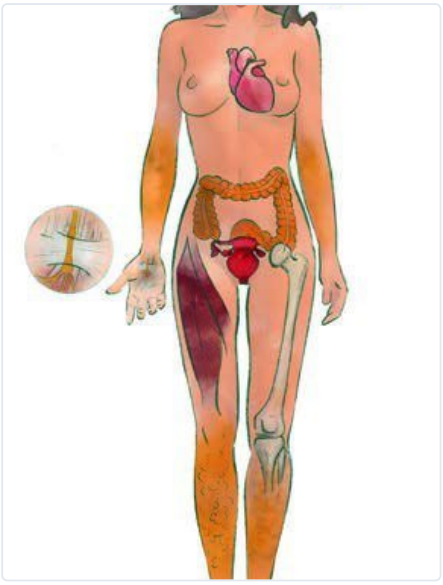
Máxima · Dosis estándar de levotiroxina, reglas de absorción, criterios de tratamiento en hipotiroidismo subclínico y ajuste en cardiópatas/ancianos

1.03.1.002 **Hipotiroidismo** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: TSH, T4, T3 · Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa)

LO QUE TE PREGUNTAN

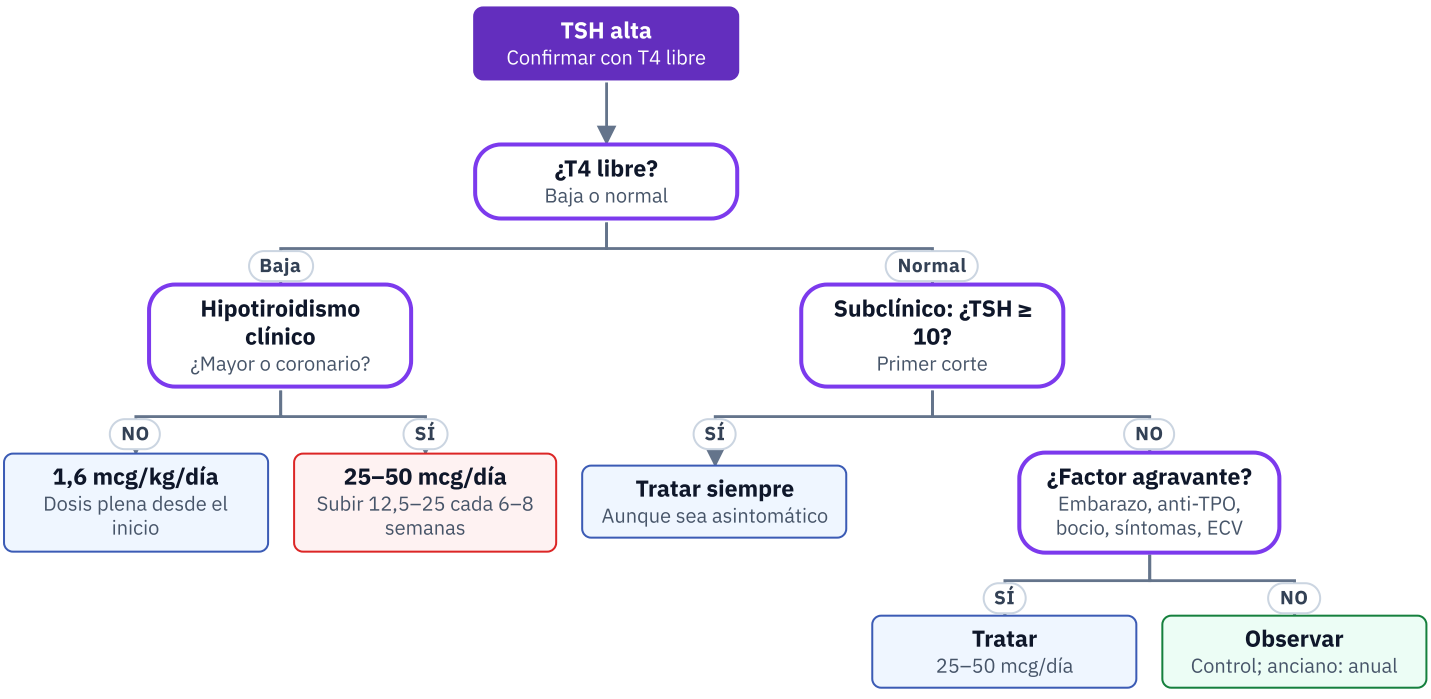
- La Tiroiditis Crónica Autoinmune de Hashimoto (Anti-TPO positivo) es la causa número uno de hipotiroidismo primario en el adulto.
- La lentitud en la fase de relajación del reflejo aquiliano es el signo clínico físico más específico del hipotiroidismo.
- El hipotiroidismo produce dislipidemia secundaria con elevación marcada de Colesterol Total y LDL; se normaliza al compensar la TSH sin estatinas.
- El hipotiroidismo subclínico con TSH **≥ 10.0 mIU/L** se trata SIEMPRE con levotiroxina, independientemente de la presencia de síntomas.
- En hipotiroidismo subclínico con TSH entre 4.5 y 9.9 mIU/L, se trata si hay: embarazo, Anti-TPO positivo, bocio, síntomas o dislipidemia en jóvenes.
- En ancianos (> **70-80 años**) con TSH < 10 mIU/L asintomáticos, la conducta es observación, evitando el sobretratamiento y la fibrilación auricular.
- La dosis de levotiroxina es **1.6 mcg**/kg/d en jóvenes; en ancianos o cardiópatas se inicia a **25-50 mcg**/d para prevenir eventos isquémicos.



CLÍNICA DEL HIPOTIROIDISMO
Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 55

ALGORITMO · HIPOTIROIDISMO PRIMARIO Y SUBCLÍNICO EN APS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **7–10** (pág. 16) · solucionario pág. 30.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 1.2 · COMPARACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICA: HIPOTIROIDISMO PRIMARIO VS SUBCLÍNICO VS CENTRAL

PARÁMETRO	HIPOTIROIDISMO PRIMARIO CLÍNICO	HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO	HIPOTIROIDISMO CENTRAL / SECUNDARIO
Etiología Principal	Tiroiditis de Hashimoto (autoinmune, Anti-TPO)	Etapa temprana de Hashimoto o post-tiroiditis	Adenoma hipofisario, Sheehan, cirugía/RDT craneal
Nivel de TSH	ELEVADA (> 4.5 a > 100 mIU/L)	ELEVADA (4.5 a 9.9 mIU/L)	Baja o "Normal" inapropiada (1.0-3.0 mIU/L)
Nivel de T4 Libre	DISMINUIDA (< 0.8 ng/dL)	NORMAL (0.8 a 1.8 ng/dL)	DISMINUIDA (< 0.8 ng/dL)
Clínica Cardinal	Astenia, intolerancia frío, voz ronca, mixedema	Asintomático o síntomas leves inespecíficos	Astenia + hipogonadismo, hipocortisolismo asociado
Indicación de Tratamiento	UNIVERSAL en el 100% de los casos (GES)	Si TSH ≥ 10, Anti-TPO (+), síntomas o embarazo	Levotiroxina previa confirmación de eje suprarrenal
Dosis Inicial Estándar	1.6 mcg/kg/d (jóvenes) · 25-50 mcg (ancianos)	25 a 50 mcg/día con ajuste según TSH	Según peso; monitorear con T4L (no con TSH)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Subclínico con TSH ≥ 10	Levotiroxina siempre	Observar porque es asintomático
Subclínico 4,5–9,9 sin factores	Control de TSH	Iniciar levotiroxina
Mayor de 70–80 años, TSH < 10, asintomático	Observación anual	Tratar y causar arritmia

REGLA DE ORO **Ayuno estricto, con agua pura** — 30 a 60 min antes del desayuno

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El hipotiroidismo primario es una de las enfermedades endocrinas más prevalentes en Chile (afecta a cerca del 10% de la población adulta, especialmente mujeres) y cuenta con cobertura prioritaria en las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 35). El EUNACOM examina con intensidad las indicaciones exactas de inicio de levotiroxina en hipotiroidismo subclínico, la titulación de dosis según edad y riesgo cardiovascular, las estrictas reglas de administración para no comprometer su absorción intestinal y la periodicidad del control bioquímico.

TABLA 1.2.B · PROTOCOLO DE INICIO Y TITULACIÓN DE LEVOTIROXINA SEGÚN GRUPO DE PACIENTES

GRUPO DE PACIENTES	DOSIS INICIAL DE LEVOTIROXINA	AJUSTE DE DOSIS	META DE TSH EN CONTROL
Adulto joven sin antecedentes cardíacos	1.6 mcg/kg/día dosis plena (75–125 mcg/d)	Ajustes de 12.5 a 25 mcg según TSH c/6-8 sem	0.5 a 2.5 mIU/L
Adulto mayor (> 65 años) sin cardiopatía	25 a 50 mcg/día en ayunas	Aumentar 12.5 a 25 mcg cada 6 a 8 semanas	1.0 a 3.5 mIU/L (meta más laxa)
Cardiopatía coronaria / Insuficiencia cardíaca	12.5 a 25 mcg/día ("Start low, go slow")	Aumentar 12.5 mcg cada 6 a 8 semanas con ECG	1.0 a 3.5 mIU/L (evitar taquicardia)
Gestante con hipotiroidismo previo	Aumentar 20–30% la dosis al confirmar embarazo	Control de TSH cada 4 semanas hasta sem 20	< 2.5 mIU/L en 1° trimestre; < 3.0 en 2° y 3°

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **7–10** (pág. 16) · solucionario pág. 30.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

1.3 Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.03.2.002 Mixedema

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Hipotiroidismo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El coma mixedematoso es una urgencia vital con **30-50%** de mortalidad; ocurre típicamente en ancianas expuestas al frío o sepsis.
- **La tríada clásica es**: Hipotermia profunda (< **35 °C**) + Hiponatremia dilucional + Sopor/Coma con bradicardia e hipoventilación.
- **¡REGLA ABSOLUTA DE ORO!**: Administrar SIEMPRE Hidrocortisona EV (**100 mg**) ANTES o junto con la levotiroxina para evitar crisis suprarrenal fatal.
- La levotiroxina acelera la degradación metabólica hepática del cortisol; si no se da corticoide previo, el paciente fallece por shock suprarrenal.
- La dosis de carga de levotiroxina es de **300 a 500 mcg** por vía endovenosa (o sonda nasogástrica), seguida de **50-100 mcg** diarios.



MIXEDEMA GRAVE
Wikimedia Commons «Myxedema face.png», CC BY 2.5, Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk

ALGORITMO · RESCATE DEL COMA MIXEDEMATOSO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

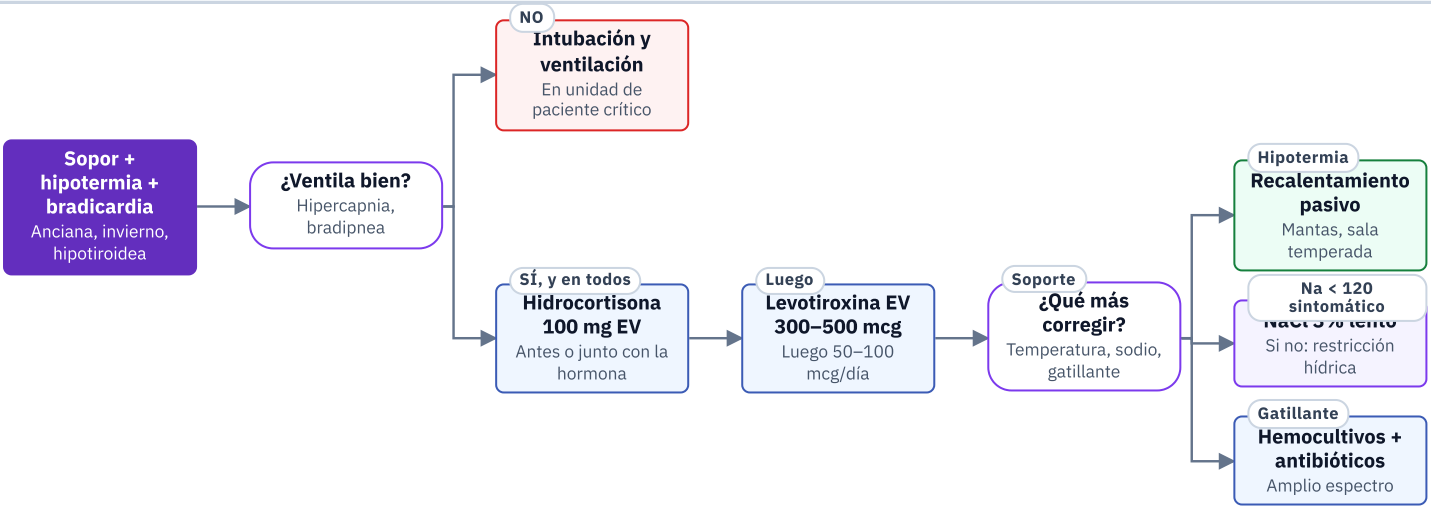


TABLA 1.3 · MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ALTERACIONES DE LABORATORIO EN COMA MIXEDEMATOSO

SISTEMA ORGÁNICO	MANIFESTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	HALLAZGO DE LABORATORIO CLAVE	RIESGO VITAL INMEDIATO
Termorregulación	Hipotermia severa (< 35.0 °C, hasta 30 °C)	Carencia de termogénesis tiroidea	Fibrilación ventricular y parada cardíaca
Neurológico	Sopor, estupor, psicosis o coma profundo	Hiponatremia hiposmolar severa (Na < 120)	Edema cerebral y enclavamiento
Cardiovascular	Bradicardia extrema, shock refractario a volumen	Derrame pericárdico, bajo voltaje en ECG	Colapso hemodinámico y shock cardiogénico
Respiratorio	Hipoventilación, bradipnea, respiración superficial	Acidosis respiratoria grave (pH < 7.20, PaCO2 > 60)	Paro respiratorio por falla del centro ventilatorio
Endocrino/Metabólico	Facies mixedematosa, piel apergaminada	TSH > 50-100 mIU/L, T4L indetectable, hipoglicemia	Crisis suprarrenal aguda concomitante

TRAMPAS EUNACOM

INTERVENCIÓN	CORRECTO	ERROR FRECUENTE
Corticoide	Hidrocortisona 100 mg EV, antes o junto	Levotiroxina sola, o esperar el cortisol
Hormona tiroidea	Levotiroxina 300–500 mcg EV de carga	Vía oral por un intestino con íleo
Temperatura	Recalentamiento pasivo con mantas	Baño caliente o manta eléctrica

REGLA DE ORO **Anciana, invierno, fría y soporosa** — Con bradicardia e hiponatremia

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **11–15** (págs. 16–17) · solucionario págs. 30–31.

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

1.4 Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.002 Hipotiroidismo — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Hipotiroidismo · Pruebas tiroideas

LO QUE TE PREGUNTAN

- **En el embarazo la meta de TSH es más estricta**: < 2.5 mIU/L en el 1° trimestre y < 3.0 mIU/L en el 2° y 3° trimestre.
- Toda mujer con hipotiroidismo previo debe aumentar su dosis de levotiroxina en un **20-30%** apenas confirme el atraso menstrual.
- En la gestante se debe tratar todo hipotiroidismo con TSH > 2.5 mIU/L para prevenir pérdidas fetales y retraso psicomotor.
- El tamizaje neonatal universal de hipotiroidismo congénito se realiza por punción de talón en papel filtro entre las 40 y **48 horas** de vida.
- La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es la Disgenesia Tiroidea (ectopia tiroidea y agenesia en > **85%**).
- El tratamiento con levotiroxina (**10-15 mcg**/kg/d) debe iniciarse ANTES de los **15 días** de vida para prevenir el cretinismo y retraso mental.



SIN TRATAMIENTO
Nelson 22.ª ed., p. 4372

ALGORITMO · HIPOTIROIDISMO GESTACIONAL Y TAMIZAJE NEONATAL

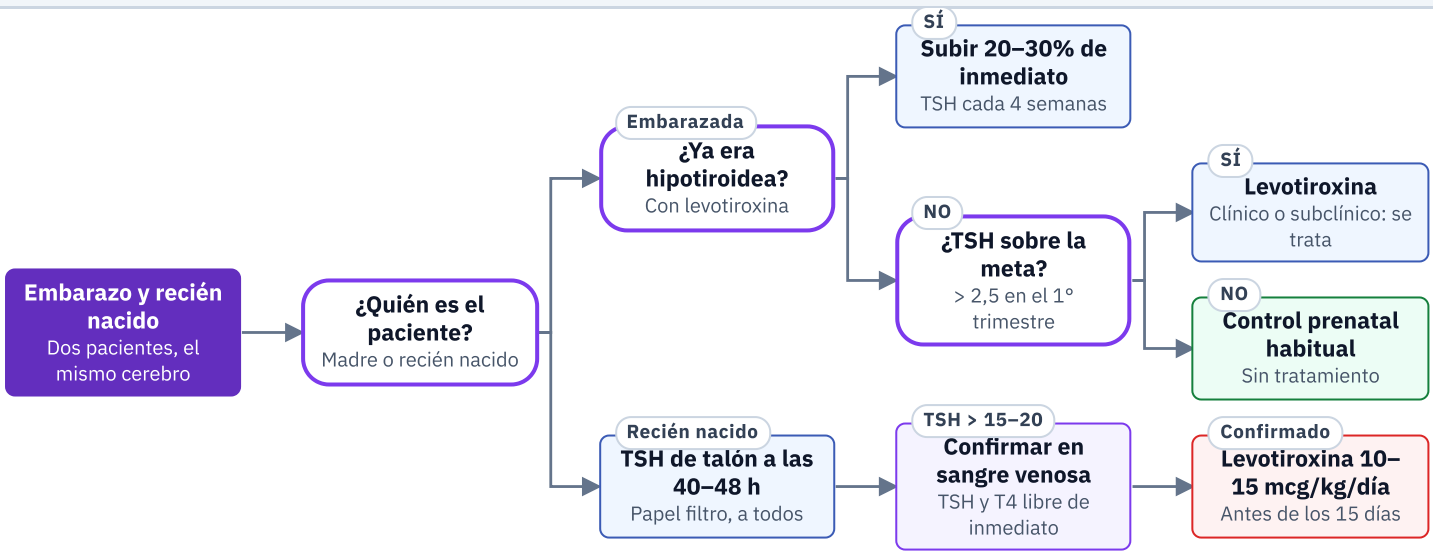


TABLA 1.4 · COMPARACIÓN ENTRE HIPOTIROIDISMO GESTACIONAL E HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

ASPECTO CLÍNICO	HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO	HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO NEONATAL
Población Objetivo	Mujer gestante (tamizaje en primer control prenatal)	Todo recién nacido vivo en Chile (Tamizaje Universal GES)
Método Diagnóstico	TSH y T4 Libre plasmáticas venosas en sangre materna	Medición de TSH en sangre de talón en papel filtro (40-48h vida)
Umbral de Intervención	TSH > 2.5 mIU/L (1° trim) o > 3.0 mIU/L (2°-3° trim)	TSH de talón > 15 a 20 mIU/L (confirmación venosa urgente)
Causa más Frecuente	Tiroiditis autoinmune crónica (Hashimoto)	Disgenesia tiroidea (ectopia tiroidea lingual / sublingual en 60%)
Riesgo del No Tratamiento	Aborto espontáneo, preeclampsia, bajo peso, déficit cognitivo	Cretinismo, retraso mental severo irreversible, enanismo
Tratamiento de Elección	Levotiroxina oral en ayunas (subir dosis 25-30% precoz)	Levotiroxina 10 a 15 mcg/kg/día VO iniciada ANTES de 15 días de vida

REGLA DE ORO **TSH < 2,5 en el 1° trimestre** — < 3,0 en el 2° y 3°

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **16–17** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

1.5 Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

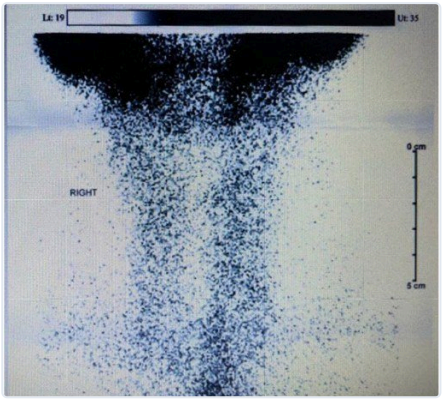
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.005 Tiroiditis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Hipertiroidismo · Hipotiroidismo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Tiroiditis de De Quervain es la causa más común de tiroides DOLOROSA; presenta dolor exquisito cervical irradiado a oídos y mandíbula.
- El cintigrama tiroideo en De Quervain y en tiroiditis destructivas muestra captación de I-131 CASI NULA (< **1%**), a diferencia de Graves.
- La VHS marcadamente elevada (> **60-100 mm**/h) asociada a dolor tiroideo es el marcador de laboratorio cardinal de De Quervain.
- El tratamiento de De Quervain se basa en AINEs en casos leves a moderados y corticoides (prednisona) en casos severos o refractarios.
- Los fármacos antitiroideos (tiamazol) NO sirven en las tiroiditis destructivas porque no hay hiperfunción glandular sino lisis con fuga hormonal.



CINTIGRAMA EN BLANCO
Open-i (NLM), CC BY

ALGORITMO · TIROIDITIS: ¿DUELE Y CAPTA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

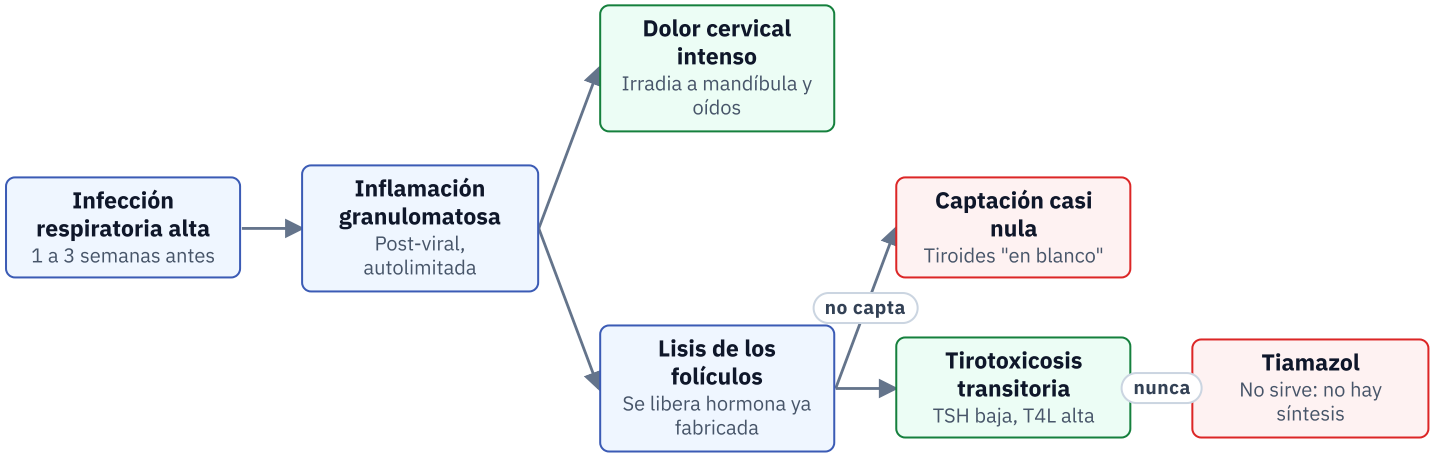


TABLA 1.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES TIROIDITIS CLÍNICAS

TIPO DE TIROIDITIS	DOLOR CERVICAL	VHS / PCR	ANTI-TPO	CAPTACIÓN I-131	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
De Quervain (Subaguda)	SÍ (Intenso, irradiado a mandíbula)	MUY ALTA (> 60-100 mm/h)	Negativo o títulos bajos	CASI NULA (< 1%, "Blanco")	AINEs / Prednisona 30-40 mg/d + Propranolol
Hashimoto (Crónica autoinmune)	NO (Indoloro, bocio firme elástico)	Normal	POSITIVO ALTO (> 90%)	Variable / Irregular	Levotiroxina de por vida según TSH (GES)
Silente o Postparto	NO (Totalmente indolora)	Normal o levemente alta	Positivo moderado (50-70%)	Casi nula en fase tirotóxica	Propranolol en fase 1; L-T4 transitoria si hipo
Amiodarona Tipo 1 (Jod-Basedow)	NO	Normal	Variable	Baja o detectable	Antitiroideos (Tiamazol a altas dosis)
Amiodarona Tipo 2 (Destructiva)	NO (o molestia leve)	Normal o levemente alta	Negativo	NULA / Indetectable	Corticoides orales (Prednisona 40 mg/d)
Infecciosa Supurada Aguda	SÍ (Eritema, calor local, fluctuación)	Alta con Leucocitosis	Negativo	Normal con defecto focal	Drenaje quirúrgico + Antibióticos EV

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

TIROIDITIS	PISTA CLAVE	TRATAMIENTO
Litio	Bocio + TSH alta	Mantener litio + levotiroxina

REGLA DE ORO **Dolor + VHS alta + captación nula** — De Quervain

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, pregunta **18** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

Clase 1.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

★★☆
PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

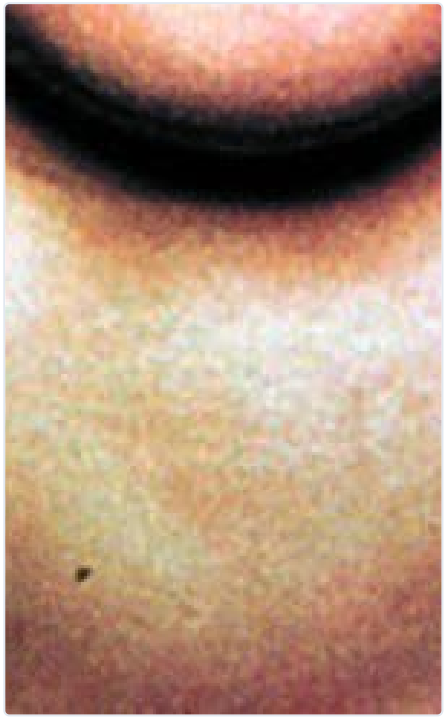
MUY ALTA

1.03.1.003 **Hipertiroidismo** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Orbitopatía tiroidea · TSH, T4, T3

LO QUE TE PREGUNTAN

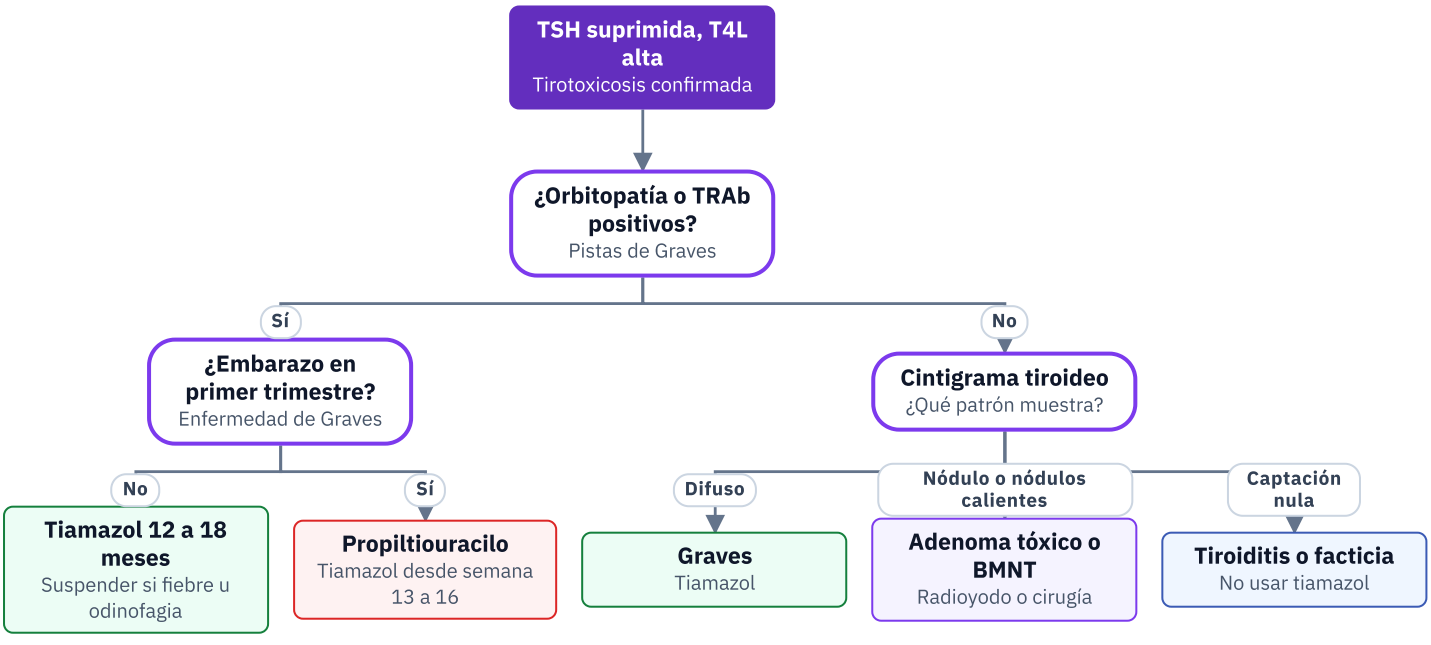
- La Enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo en menores de **50 años**; es mediada por anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TRAb/TSI).
- El bocio difuso con soplo/frémito, la orbitopatía distiroidea y el mixedema pretibial son signos clínicos PATOGNOMÓNICOS de Graves.
- El cintigrama tiroideo discierne entre tirotoxicosis con captación alta (Graves, adenoma tóxico, BMNT) y captación baja o nula (tiroiditis subaguda, tiroiditis facticia).
- El fármaco de elección general es el Tiamazol (**10-30 mg**/día). El PTU se reserva exclusivamente para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea.
- La complicación más temida de las tionamidas es la Agranulocitosis (RAN < 500/uL). Regla de oro: si presenta fiebre o faringitis, suspender el fármaco de inmediato y pedir hemograma urgente.
- El radioyodo I-131 está absolutamente contraindicado en el embarazo y lactancia, y contraindicado relativamente en orbitopatía distiroidea moderada-severa activa.
- Si se indica I-131 en un paciente con Graves y orbitopatía activa leve a moderada, es obligatorio administrar profilaxis con prednisona oral (**0.4-0.5 mg/kg**/día) por **6 semanas**.



BOCIO DIFUSO
Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 57

ALGORITMO · TIROTOXICOSIS: DE LA TSH SUPRIMIDA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **19–25** (págs. 18–19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 7.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 7.6 · DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DIFERENCIAL DE SÍNDROMES TIROTÓXICOS EN EUNACOM

CRITERIO / ENTIDAD	GRAVES-BASEDOW	BOCIO MULTINODULAR TÓXICO	ADENOMA TÓXICO	TIROIDITIS SUBAGUDA (DE QUERVAIN)	TIROTOXICOSIS FACTICIA
Mecanismo Central	TRAb estimulante de TSHR	Mutaciones activadoras TSHR	Mutación clonal autónoma TSHR	Lisis folicular post-viral	Ingesta exógena de levotiroxina
Palpación Tiroidea	Bocio difuso, frémito/soplo	Múltiples nódulos pétreos	Nódulo único delimitado	Glándula exquisitamente dolorosa	Tiroides no palpable / atrófico
Oftalmopatía / Mixedema	Presente (patognomónica)	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Cintigrama I-131 / Tc99	Difusa y homogénea (> 40%)	Áreas calientes y frías	Nódulo caliente único supresor	Abolida / nula (< 2%)	Abolida / nula (< 1%)
Tiroglobulina Sérica	Elevada	Elevada	Elevada	Muy elevada (lisis celular)	Indetectable (< 0.1 ng/mL)
Tratamiento de Elección	Tiamazol 12-18 m / I-131 / Cx	Radioyodo I-131 o Cirugía	I-131 o Resección quirúrgica	AINEs / Corticoides + Propranolol	Suspender aporte exógeno

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Tirotoxicosis con captación nula	Buscar tiroiditis o hormona exógena	Iniciar tiamazol
Graves con TRAb + u orbitopatía	Diagnóstico hecho	Pedir cintigrama igual
TSH suprimida con T4L normal	Medir T3 libre	Llamarlo subclínico sin más

REGLA DE ORO **Captación alta: hiperfunción** — Captación nula: no hay que bloquear

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La tirotoxicosis es el estado clínico resultante del exceso de hormonas tiroideas circulantes. En Chile y el mundo, la Enfermedad de Graves-Basedow representa el 70-80% de los casos de hipertiroidismo en menores de 50 años. Su etiología autoinmune (anticuerpos estimulantes del receptor de TSH o TRAb) genera una hiperfunción folicular autónoma y bocio difuso. EUNACOM evalúa con máxima frecuencia el diagnóstico diferencial frente a tiroiditis destructivas (captación baja vs alta), las manifestaciones extratiroideas patognomónicas (oftalmopatía infiltrativa y mixedema pretibial), la titulación de fármacos antitiroideos y la detección precoz de sus complicaciones fatales (agranulocitosis).

TABLA 7.6.B · ALGORITMO TERAPÉUTICO Y MANEJO FARMACOLÓGICO ESCALONADO

ESCENARIO CLÍNICO	FÁRMACO / MEDIDA DE PRIMERA LÍNEA	DOSIS / ESQUEMA HABITUAL	META / PRECAUCIÓN OBLIGATORIA
Graves: Inicio Adulto General	Tiamazol oral	15-30 mg/día en 1 toma matinal	Ajustar con T4L a las 4-6 sem. Suspender ante fiebre/odinofagia
Graves: Gestación 1er Trimestre	Propiltiouracilo (PTU) oral	50-100 mg cada 8 horas	Evitar embriopatía por tiamazol. Cambiar a tiamazol en sem 13-16
Síntomas Adrenérgicos Activos	Propranolol o Atenolol	Propranolol 20-40 mg c/8h o Atenolol 50 mg/d	Meta FC 60-80 lpm. Precaución en asma severa descompensada
Recidiva post-fármacos o BMNT	Radioyodo I-131	10 a 15 mCi vía oral en ayuno	Descartar embarazo. Prednisona 30 mg/d si orbitopatía activa
Agranulocitosis por Tionamida	Hospitalización + Aislamiento + G-CSF	Filgrastim 5 mcg/kg/día subcutáneo	Suspensión definitiva de tionamidas; NUNCA reexponer

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **19–25** (págs. 18–19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 7.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.7 Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía

★★☆
PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.003 Hipertiroidismo — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Patología benigna del tiroides

LO QUE TE PREGUNTAN

- El tiamazol es el fármaco de elección inicial para la Enfermedad de Graves en adultos no embarazadas debido a su potencia y dosificación en 1 toma diaria.
- El PTU se reserva de forma estricta para el 1er trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea por su mayor riesgo de necrosis hepática fulminante.
- El I-131 está absolutamente contraindicado durante el embarazo y la lactancia; en mujeres fértiles exige posponer la concepción al menos **6 meses** post-dosis.
- El hipotiroidismo permanente es el resultado natural y buscado tras la terapia con I-131 o tiroidectomía total, requiriendo sustitución con levotiroxina de por vida.
- La preparación prequirúrgica de la tiroidectomía exige eutiroidismo previo con tiamazol y administración de solución de Lugol durante los **7-10 días** previos para colapsar la vascularización.
- Las principales complicaciones de la tiroidectomía total son el hipoparatiroidismo transitorio o definitivo (hipocalcemia) y la lesión del nervio laríngeo recurrente (disfonía).



GRAVES: CAPTACIÓN DIFUSA
Manual AMIR Endocrinología, p. 44

ALGORITMO · HIPERTIROIDISMO: ELEGIR EL TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

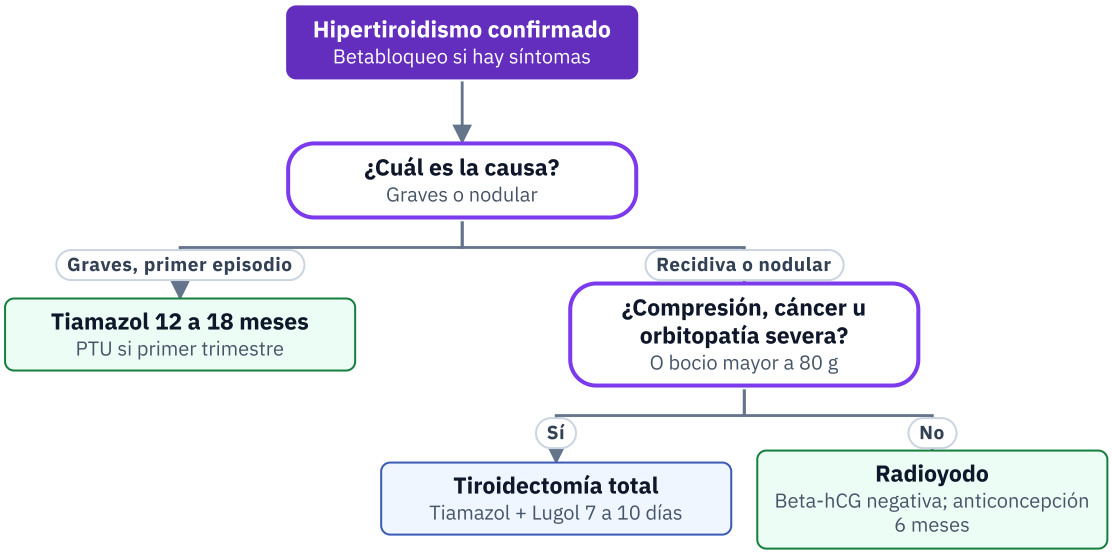


TABLA 7.7 · COMPARACIÓN TERAPÉUTICA EN HIPERTIROIDISMO: FÁRMACOS VS RADIOYODO VS CIRUGÍA

MODALIDAD	VENTAJAS PRINCIPALES	DESVENTAJAS / RIESGOS CLAVE	INDICACIÓN PREDILECTA EUNACOM
Tiamazol (Tionamidas)	No ablativo, conserva la glándula, remisión ~40-50%	Agranulocitosis (0.3%), hepatitis colestásica, recidiva 50%	Primer episodio de Graves en jóvenes o preparación quirúrgica
Propiltiouracilo (PTU)	Bloquea conversión periférica T4->T3, menor teratogénesis temprana	Hepatitis fulminante letal (caja negra FDA), requiere 3 tomas/día	Graves en 1er trimestre gestacional y Tormenta Tiroidea
Radioyodo (I-131)	Ablación definitiva, no invasivo, alta tasa de curación	Hipotiroidismo definitivo (> 80%), empeora orbitopatía activa	Recidiva de Graves, BMNT, nódulo tóxico, alto riesgo quirúrgico
Tiroidectomía Total	Resolución inmediata, ideal para bocios gigantes compresivos	Hipoparatiroidismo permanente (1-2%), lesión nervio laríngeo recurrente	Bocio gigante (> 80 g), sospecha de cáncer, orbitopatía activa severa

REGLA DE ORO **Tiamazol de elección** — PTU: primer trimestre y tormenta

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **26–27** (pág. 19) · solucionario pág. 33.

Clase 7.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.8 Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

ALTA

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.03.2.001 **Tormenta tiroidea** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

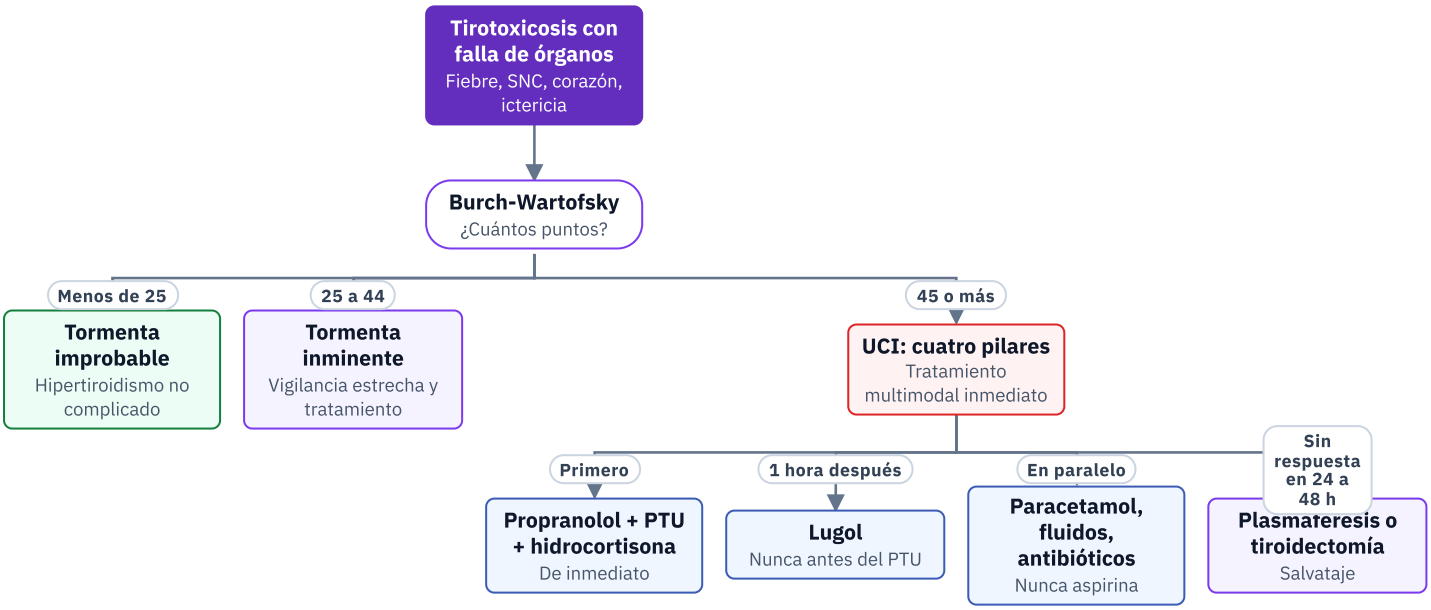
También: Hipertiroidismo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Tormenta Tiroidea es una emergencia endocrinológica con alta mortalidad; su diagnóstico es CLÍNICO y se define operativamente con la Escala de Burch-Wartofsky **≥ 45 puntos**.
- No se diferencia del hipertiroidismo común por la concentración absoluta de T**4L**/T3, sino por la falla sistémica multiorgánica (SNC, cardiovascular, termorregulación, digestivo).
- **El tratamiento comprende 4 pilares obligatorios**: Betabloqueadores + Tionamidas (PTU preferido) + Yodo inorgánico + Corticoides sistémicos.
- **REGLA TEMPORAL CRÍTICA**: El yodo inorgánico (Lugol o SSKI) debe administrarse al menos **60 minutos** DESPUÉS del PTU para evitar el fenómeno de Jod-Basedow.
- El PTU es superior al tiamazol en la tormenta porque bloquea de forma rápida la conversión periférica de T4 a T3.
- La hidrocortisona EV (**100 mg** cada **8 horas**) previene el colapso cardiovascular por agotamiento suprarrenal relativo y frena la desyodación periférica.
- **CONTRAINDICACIÓN ESTRICTA**: NUNCA administrar Aspirina (ácido acetilsalicílico), ya que desplaza a las hormonas tiroideas de la TBG y eleva catastróficamente la fracción libre.

ALGORITMO · TORMENTA TIROIDEA: RESCATE EN ORDEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **28–32** (págs. 19–20) · solucionario pág. 34.

Clase 7.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.8 Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

PRIORIDAD BAJA

TABLA 7.8 · ESCALA DE BURCH-WARTOFSKY POINT SCALE (BWPS) PARA DIAGNÓSTICO DE TORMENTA TIROIDEA

SISTEMA ORGÁNICO	CRITERIO CLÍNICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO	INTERPRETACIÓN GLOBAL
Termorregulación	37.2-37.7°C (5) / 37.8-38.2°C (10) / 38.3-38.8°C (15) / 38.9-39.4°C (20) / 39.5-39.9°C (25) / ≥40.0°C (30)	5 a 30 puntos	≥ 45 puntos:
Efectos en SNC	Leve: agitación (10) / Moderado: delirio, psicosis, letargia extrema (20) / Severo: convulsiones o coma (30)	10 a 30 puntos	TORMENTA TIROIDEA
Disfunción Gastrointestinal	Moderada: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal (10) / Severa: ictericia de causa inexplicable (20)	10 a 20 puntos	ALTAMENTE PROBABLE
Disfunción Cardiovascular	FC 100-109 (5) / 110-119 (10) / 120-129 (15) / 130-139 (20) / ≥ 140 lpm (25)	5 a 25 puntos	25 a 44 puntos:
Arritmias e Insuficiencia Cardíaca	Fibrilación auricular (10) / ICC leve (5) / ICC moderada con crépitos (10) / Edema pulmonar franco (15)	5 a 25 puntos	Tormenta Inminente
Factor Desencadenante	Presencia de evento precipitante agudo identificado (infección, trauma, cirugía, parto, contraste)	10 puntos	< 25 puntos: Improbable

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Sospecha clínica, BWPS ≥ 45	Tratar de inmediato en UCI	Esperar la T4L
Elegir la tionamida	Propiltiouracilo	Tiamazol
Momento del Lugol	≥ 1 hora después del PTU	Darlo antes o junto al PTU
Fiebre	Paracetamol + medidas físicas	Aspirina
Corticoide	Hidrocortisona 100 mg EV c/8 h	Omitirlo

REGLA DE ORO **Burch-Wartofsky 45 o más** — Tratar sin esperar exámenes

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La tormenta tiroidea representa la máxima expresión de descompensación tirotóxica, constituyendo una emergencia médica extrema con una mortalidad histórica del 10 al 30% si no se instaura un tratamiento precoz y agresivo. No se distingue del hipertiroidismo no complicado por el nivel absoluto de T4 libre o T3, sino por el colapso homeostático multiorgánico sistémico desencadenado por factores intercurrentes (infecciones bacterianas, cirugía tiroidea o no tiroidea sin preparación previa, cetoacidosis, parto o suspensión brusca de antitiroideos). EUNACOM evalúa el diagnóstico clínico rápido mediante los criterios de Burch-Wartofsky, el orden temporal estricto de los fármacos de rescate y la prohibición absoluta de administrar aspirina.

TABLA 7.8.B · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO MULTIMODAL INMEDIATO DE TORMENTA TIROIDEA

FÁRMACO / PASO	DOSIS DE ATAQUE Y MANTENIMIENTO	MECANISMO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN CRÍTICA EUNACOM
1. Betabloqueador	Propranolol 60-80 mg c/4-6h oral/SNG (o 1 mg EV lento)	Bloquea tono simpático y conversión T4->T3	Primera acción para frenar taquiarritmias colapsantes
2. Tionamida	Propiltiouracilo 500-1000 mg ataque, luego 250 mg c/4h	Inhibe síntesis tiroidea y conversión periférica	De elección sobre tiamazol; administrar ANTES que el yodo
3. Yoduro Inorgánico	Solución de Lugol 8-10 gotas c/8h oral/SNG (o SSKI)	Bloqueo agudo de liberación (Wolff-Chaikoff)	OBLIGATORIO: Dar ≥ 1 hora DESPUÉS del PTU
4. Glucocorticoide	Hidrocortisona 100 mg EV c/8h (o Dexametasona 2 mg c/6h)	Trata hipocortisolismo relativo y bloquea T4->T3	Previene colapso por agotamiento suprarrenal
5. Antipirético	Paracetamol 1 g EV o enteral cada 6 horas	Control térmico hipotalámico	PROHIBIDA LA ASPIRINA (desplaza T4/T3 de TBG)

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **28–32** (págs. 19–20) · solucionario pág. 34.

Clase 7.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

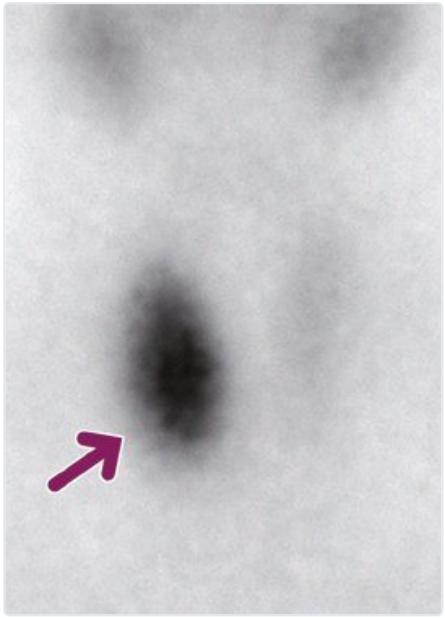
MUY ALTA

1.03.1.021 **Nódulo tiroídeo** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ecografía tiroídea · Bocio

LO QUE TE PREGUNTAN

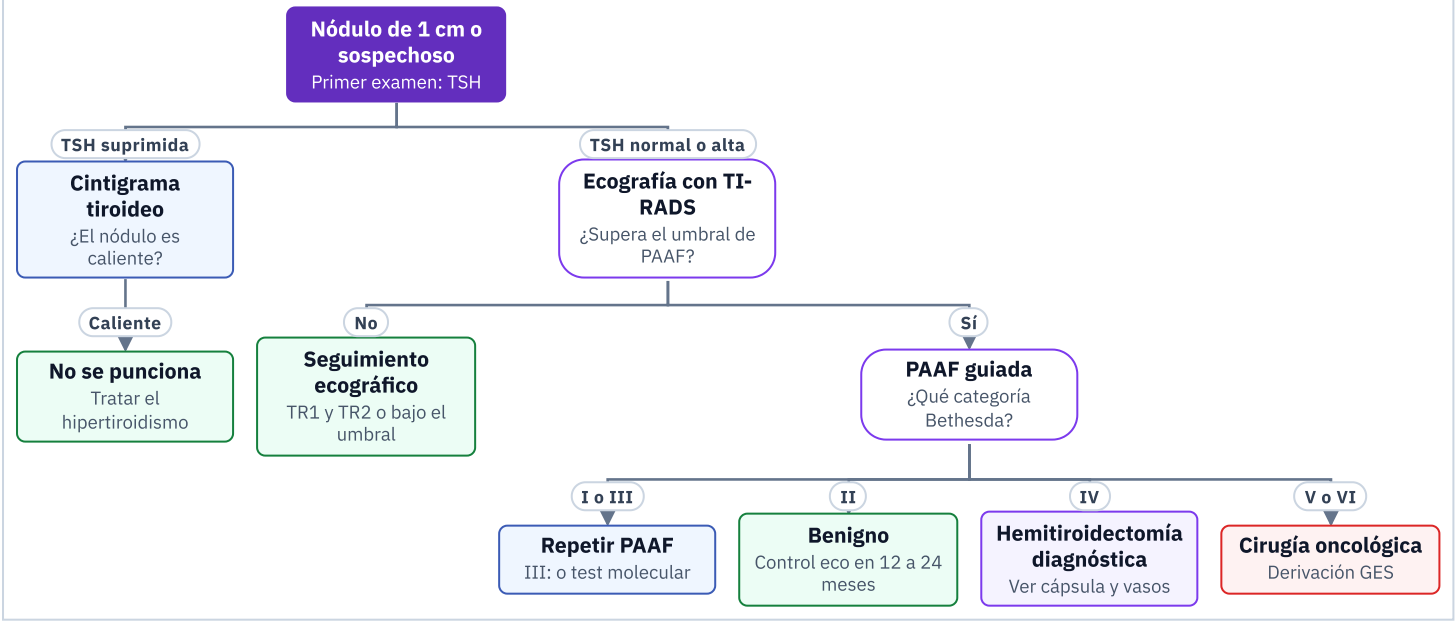
- Ante cualquier nódulo tiroideo sospechoso o **≥ 1 cm**, el PRIMER examen obligatorio es la TSH sérica.
- Si la TSH está suprimida (< 0.4 mIU/L), se solicita Cintigrama Tiroideo; los nódulos 'calientes' prácticamente nunca son malignos y NO requieren PAAF.
- Si la TSH es normal o elevada, el estudio de rigor es la Ecografía Tiroidea de Alta Resolución con clasificación TI-RADS.
- **Los 5 signos ecográficos de alta sospecha de malignidad son**: nódulo sólido, hipoecogénico, márgenes irregulares, microcalcificaciones y más alto que ancho.
- **Umbrales de tamaño para PAAF según ACR TI-RADS**: TR5 **≥ 1.0 cm**; TR4 **≥ 1.5 cm**; TR3 **≥ 2.5 cm**. Nódulos < **1.0 cm** no se puncionan rutinariamente.
- La citología se informa según el Sistema Bethesda (I a VI). Bethesda II es benigno (seguimiento ecográfico), Bethesda VI es maligno (cirugía).
- Bethesda IV (Neoplasia folicular) NO puede distinguir en la PAAF entre adenoma y carcinoma (requiere ver invasión vascular o capsular en pieza quirúrgica); la conducta es Hemitiroidectomía diagnóstica.



GAMMAGRAFÍA: NÓDULO CALIENTE
Manual AMIR Endocrinología, p. 44

ALGORITMO · NÓDULO TIROIDEO: DE LA TSH A LA CITOLOGÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **33–36** (pág. 20) · solucionario pág. 35.

Clase 7.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 7.9 · SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ECOGRÁFICA ACR TI-RADS Y PUNTOS DE CORTE PARA PAAF

CATEGORÍA ACR	DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS CLAVE	RIESGO DE MALIGNIDAD	UMBRAL PARA PAAF GUIADA POR ECO	UMBRAL DE SEGUIMIENTO ECO
TR1 (Benigno)	Quiste simple anecoico, nódulo completamente esponjoso	< 2%	No requiere PAAF	No requiere seguimiento
TR2 (No sospechoso)	Mixto quístico-sólido sin rasgos de sospecha, isoecoico	< 2%	No requiere PAAF	No requiere seguimiento
TR3 (Leve sospecha)	Sólido isoecoico o hiperecoico, márgenes lisos	~5%	PAAF si tamaño ≥ 2.5 cm	Seguimiento si ≥ 1.5 cm
TR4 (Sospecha moderada)	Sólido hipoecoico con márgenes lisos o microquístico sospechoso	10 - 20%	PAAF si tamaño ≥ 1.5 cm	Seguimiento si ≥ 1.0 cm
TR5 (Alta sospecha)	Hipoecoico sólido + más alto que ancho + microcalcificaciones	70 - 90%	PAAF si tamaño ≥ 1.0 cm	Seguimiento si ≥ 0.5 cm

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Nódulo + TSH menor de 0,4	Cintigrama tiroideo	PAAF de entrada
Nódulo + TSH normal o alta	Ecografía con TI-RADS	Pedir cintigrama
TR5 de 0,7 cm, sin adenopatías	Seguimiento ecográfico en 6 a 12 meses	Puncionar por sospechoso

REGLA DE ORO **TSH suprimida: cintigrama** — Nódulo caliente: no se punciona

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El nódulo tiroideo es una de las consultas más prevalentes en la práctica médica ambulatoria. Aunque hasta un 50-60% de las mujeres adultas asintomáticas presentan nódulos detectables por ecografía, solo el 5-10% corresponden a lesiones malignas (predominantemente carcinoma papilar). La misión fundamental del médico en la atención primaria y en EUNACOM consiste en estratificar el riesgo mediante un algoritmo riguroso que evite la sobreintervención de nódulos benignos indolentes y asegure el diagnóstico citológico oportuno de lesiones malignas mediante punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía.

TABLA 7.9.B · CONDUCTA MÉDICA ESCALONADA SEGÚN TAMAÑO, IMAGEN Y CITOLOGÍA

ESCENARIO CLÍNICO	EXAMEN INDICADO DE ENTRADA	CRITERIO DECISORIO	CONDUCTA TERAPÉUTICA FINAL
Nódulo palpado + TSH < 0.4	Cintigrama Tiroideo I-131/Tc99	Nódulo caliente hipercaptante	NO puncionar; tratar hipertiroidismo (I-131/Cirugía)
Nódulo palpado + TSH normal	Ecografía Tiroidea de Alta Resolución	Evaluar criterios ACR TI-RADS	PAAF guiada por eco según umbrales de tamaño
Nódulo TR5 de 1.4 cm	PAAF guiada por ecografía	Obtención de cilindro citológico	Si Bethesda II observar; si Bethesda VI tiroidectomía
Nódulo TR5 de 0.7 cm sin adenopatías	Seguimiento Ecográfico a 6-12 meses	No cumple umbral PAAF (≥ 1.0 cm)	Vigilancia activa; evitar sobrediagnóstico indolente
Nódulo con PAAF Bethesda IV	Pabellón quirúrgico programado	Necesidad de biopsia diferida	Hemitiroidectomía para evaluar invasión vascular/capsular

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **33–36** (pág. 20) · solucionario pág. 35.

Clase 7.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

7.10 Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico

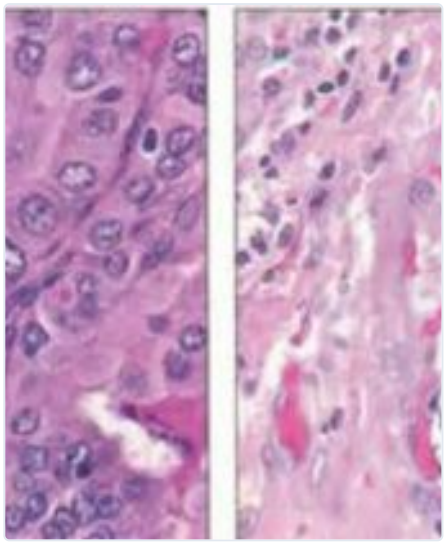
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.03.1.004
4.01.1.033
Cáncer del tiroides

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Carcinoma Papilar es el cáncer de tiroides más frecuente (**85-90%**) y de mejor pronóstico; disemina característicamente por vía LINFÁTICA cervical.
- El Carcinoma Folicular disemina por vía HEMATÓGENA hacia pulmón y huesos (metástasis osteolíticas); no se diagnostica por PAAF sino por biopsia diferida.
- El Carcinoma Medular se origina en las células C o parafoliculares secretoras de CALCITONINA; NO capta radioyodo I-131.
- Ante el diagnóstico de carcinoma medular, es OBLIGATORIO descartar feocromocitoma antes de intervenir el cuello y realizar estudio de mutaciones en el gen RET (NEM 2).
- El Carcinoma Anaplásico es extremadamente agresivo, propio de adultos mayores, con crecimiento rápido invasivo y pronóstico ominoso en pocos meses.
- La Tiroglobulina es el marcador tumoral sérico de seguimiento del carcinoma diferenciado (papilar y folicular). Siempre debe solicitarse junto a los Anticuerpos Anti-Tiroglobulina.



HISTOLOGÍA DEL PAPILAR
Pathoma, Fig. 15.5

ALGORITMO · CÁNCER DE TIROIDES: DEL SUBTIPO AL SEGUIMIENTO

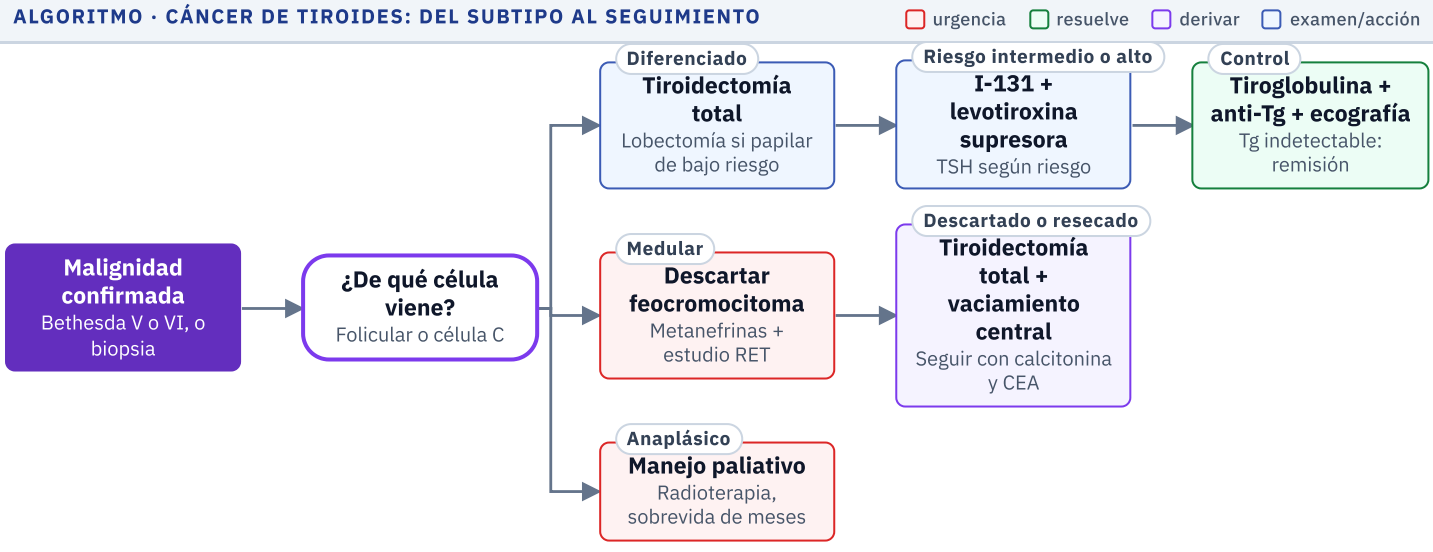


TABLA 7.10 · COMPARATIVA CLÍNICO-PATOLÓGICA DE LOS SUBTIPOS DE CÁNCER DE TIROIDES EN EUNACOM

SUBTIPO HISTOLÓGICO	FRECUENCIA / ORIGEN CELULAR	VÍA DE DISEMINACIÓN PREDILECTA	MARCADOR TUMORAL SÉRICO	RESPUESTA A RADIOYODO I-131
Carcinoma Papilar	85 - 90% / Células foliculares	Vía Linfática (ganglios cervicales)	Tiroglobulina (Tg)	Excelente (capta I-131)
Carcinoma Folicular	5 - 10% / Células foliculares	Vía Hematógena (pulmón y hueso)	Tiroglobulina (Tg)	Buena (capta I-131)
Carcinoma Medular	3 - 5% / Células C parafoliculares	Linfática y hematógena precoz	Calcitonina y CEA	NULA (no deriva de folículo)
Carcinoma Anaplásico	1 - 2% / Epitelio indiferenciado	Invasión local destructiva rápida	Ninguno confiable	NULA (comportamiento refractario)

REGLA DE ORO **Papilar: linfático · folicular: hematógeno** — Ambos: tiroglobulina y radioyodo

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Endocrinología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 7.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

7.11 Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.006 Síndrome de Cushing — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Cortisol libre 24 horas · Cortisol plasmático

LO QUE TE PREGUNTAN

- La causa más común de Síndrome de Cushing en la práctica clínica general es la IATROGÉNICA (exógena por uso de corticoides).
- Entre las causas endógenas, la Enfermedad de Cushing (microadenoma hipofisario productor de ACTH) representa el **70-80%** de los casos.
- Los signos clínicos más específicos de hipercortisolismo son la miopatía proximal, las estrías violáceas anchas (> **1 cm**) y la fragilidad capilar con hematomas fáciles.
- **El diagnóstico requiere dos fases estrictas**: 1° Demostrar hipercortisolismo con al menos 2 pruebas de 1ra línea; 2° Localizar midiendo ACTH.
- **Pruebas de primera línea**: Test de Nugent (**1 mg** dexametasona nocturna, suprime a < **1.8 mcg**/dL si sano), Cortisol Libre Urinario **24h** y Cortisol Salival Nocturno.
- Si la ACTH está suprimida (< 5 pg/mL), el origen es suprarrenal (pedir TC de suprarrenales). Si la ACTH está normal-alta o elevada, el origen es ACTH-dependiente (pedir RM de silla turca).



ESTRÍAS VIOLÁCEAS
Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 77

ALGORITMO · SÍNDROME DE CUSHING: DE LA SOSPECHA A LA CAUSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

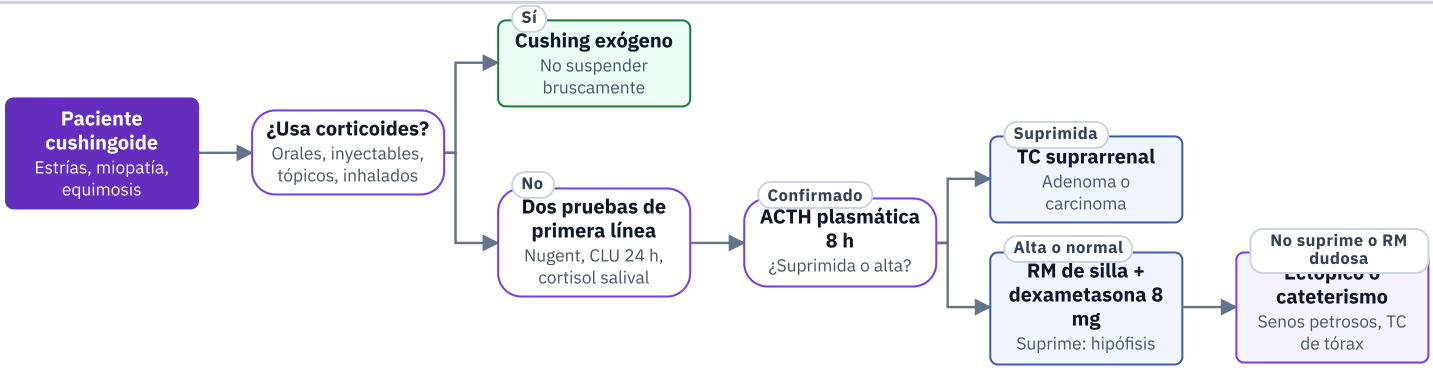


TABLA 7.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DEL SÍNDROME DE CUSHING EN EUNACOM

PARÁMETRO / PRUEBA	ENFERMEDAD DE CUSHING (HIPÓFISIS)	ADENOMA SUPRARRENAL	CARCINOMA SUPRARRENAL	SECRECIÓN ECTÓPICA DE ACTH (PULMÓN)
Frecuencia Relativa	70 - 75% de causas endógenas	10 - 12% de causas endógenas	~5% de causas endógenas	~10% de causas endógenas
ACTH Plasmática	Normal-alta o francamente elevada	Suprimida (< 5 pg/mL)	Suprimida (< 5 pg/mL)	Muy marcadamente elevada (> 100 pg/mL)
Test Nugent 1 mg	No suprime (cortisol ≥ 1.8)	No suprime (cortisol ≥ 1.8)	No suprime (cortisol ≥ 1.8)	No suprime (cortisol ≥ 1.8)
Test Dexametasona 8 mg	Suprime > 50% de cortisol basal	No suprime	No suprime	No suprime (autonomía absoluta)
Niveles de DHEA-S	Normal o ligeramente elevado	Disminuido / suprimido	Masivamente elevado + virilización	Elevado
Estudio de Imagen	RM de Silla Turca con gadolinio	TC Suprarrenal: nódulo < 4 cm lipídico	TC: masa > 4-6 cm heterogénea invasora	TC Tórax/Abdomen: tumor carcinoide / oat cell
Tratamiento de Elección	Cirugía transesfenoidal hipofisaria	Suprarrenalectomía laparoscópica	Cirugía oncológica abierta + Mitotano	Resección del tumor ectópico primario

REGLA DE ORO **Primero descartar corticoides** — La causa más frecuente es exógena

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **38–43** (pág. 21) · solucionario págs. 36–37.

Clase 7.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

7.12 Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

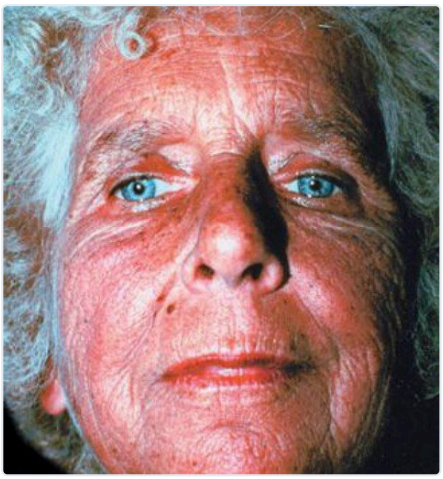
PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.007 Insuficiencia suprarrenal crónica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Cortisol plasmático

LO QUE TE PREGUNTAN

- La causa más frecuente de Enfermedad de Addison en adultos es la Adrenalitis Autoinmune (aislada o asociada a otros trastornos autoinmunes).
- La HIPERPIGMENTACIÓN de piel y mucosas es patognomónica de la insuficiencia suprarrenal primaria debido al incremento masivo de ACTH.
- La presencia de HIPERKALEMIA orienta con fuerza a insuficiencia primaria (Addison) por pérdida de aldosterona; en la secundaria el potasio es normal.
- Un cortisol matinal (08:**00 h**) < **3 mcg**/dL es diagnóstico de insuficiencia; si está entre 3 y **15 mcg**/dL se confirma con el Test de ACTH (Synacthen **250 mcg**).
- La respuesta normal al Synacthen es un ascenso del cortisol plasmático a un valor pico **≥ 18 mcg/dL** a los 30 o **60 minutos**.
- El tratamiento de la Enfermedad de Addison requiere OBLIGATORIAMENTE dos fármacos: Hidrocortisona (glucocorticoide) + Fludrocortisona (mineralocorticoide).



HIPERPIGMENTACIÓN
Fitzpatrick 7.ª ed., Fig. 152-16A

ALGORITMO · INSUFICIENCIA SUPRARRENAL: CONFIRMAR, TIPIFICAR Y TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

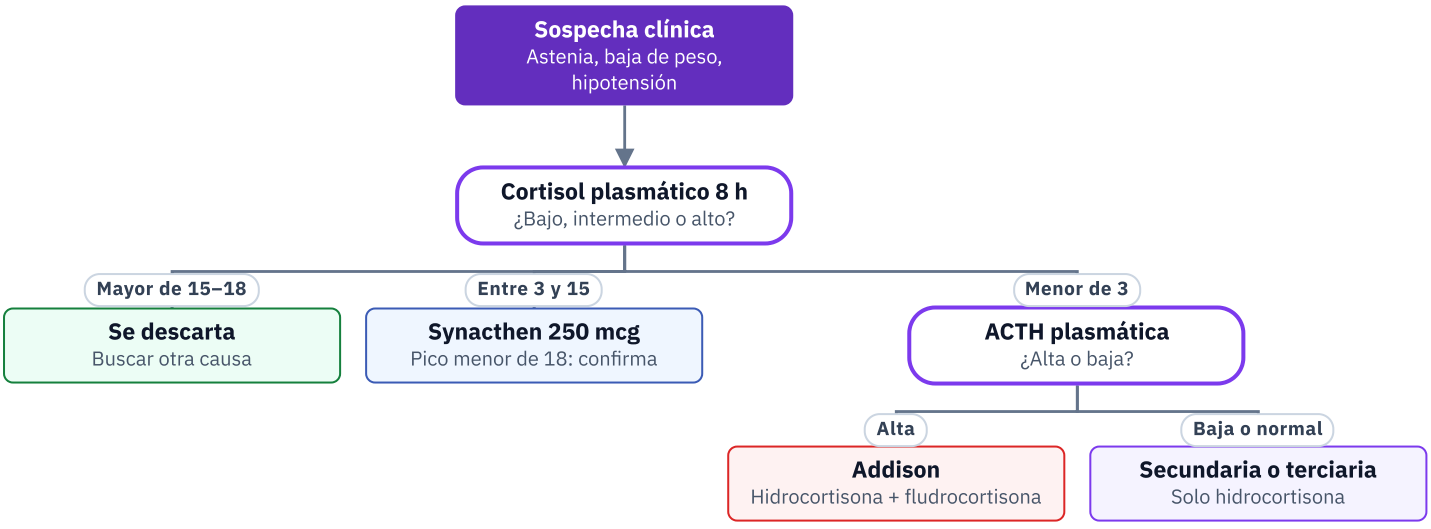


TABLA 7.12 · COMPARATIVA ENTRE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA (ADDISON) Y SECUNDARIA

CARACTERÍSTICA / PARÁMETRO	PRIMARIA (ENFERMEDAD DE ADDISON)	SECUNDARIA / TERCIARIA
Nivel de la Lesión	Corteza suprarrenal bilateral (> 90% destruida)	Hipófisis (déficit ACTH) o Hipotálamo (déficit CRH)
Etiología más Frecuente	Adrenalitis autoinmune (75-80%), TBC, metástasis	Retiro brusco de corticoides, adenoma hipofisario
Pigmentación Cutánea	Hiperpigmentación en pliegues y mucosas (ACTH alta)	Piel pálida / despigmentada ('tono alabastrino')
Potasio Plasmático	Hiperkalemia frecuente (> 5.0 mEq/L) por hipoaldosteronismo	Normal (la aldosterona está preservada por el SRAA)
Sodio Plasmático	Hiponatremia hipovolémica con pérdida renal de sal	Hiponatremia dilucional (por aumento inapropiado de ADH)
ACTH Plasmática	Francamente ELEVADA (> 100 pg/mL)	Disminuida o inapropiadamente 'normal'
Reemplazo Mineralocorticoide	Fludrocortisona OBLIGATORIA (0.05-0.1 mg/día)	NO REQUERIDA (la aldosterona endógena funciona)

REGLA DE ORO **Addison: piel oscura, potasio alto** — Secundaria: piel pálida, potasio normal

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **44–48** (pág. 22) · solucionario págs. 37–38.

Clase 7.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.03.2.003 **Insuficiencia suprarrenal aguda** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

También: Hiperplasia suprarrenal congénita · Complicaciones del tratamiento esteroidal

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Crisis Suprarrenal Aguda es una emergencia médica extrema que debuta como shock hipotensivo distributivo refractario a fluidos y aminas.
- La causa desencadenante más común es un proceso infeccioso intercurrente o gastroenteritis con suspensión involuntaria de los corticoides.
- **La tríada clínica cardinal es**: Shock/hipotensión arterial severa + Compromiso sensorial + Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal agudo y vómitos).
- **El laboratorio clásico revela la combinación crítica de**: HIPONATREMIA + HIPERKALEMIA (en Addison) + HIPOGLICEMIA SEVERA.
- **REGLA DE ORO TERAPÉUTICA**: NUNCA demorar el tratamiento a la espera de exámenes; la sospecha clínica obliga al inicio inmediato de las medidas de rescate.
- **Fármaco de elección inmediata**: Hidrocortisona **100 mg** en bolo endovenoso directo, seguido de **50-100 mg** EV cada **6 horas**.



PÚRPURA FULMINANTE
Harrison 21.ª ed., Fig. 19-7 (de Fitzpatrick, Color Atlas 8.ª ed.)

ALGORITMO · CRISIS SUPRARRENAL: DEL SHOCK AL RESCATE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

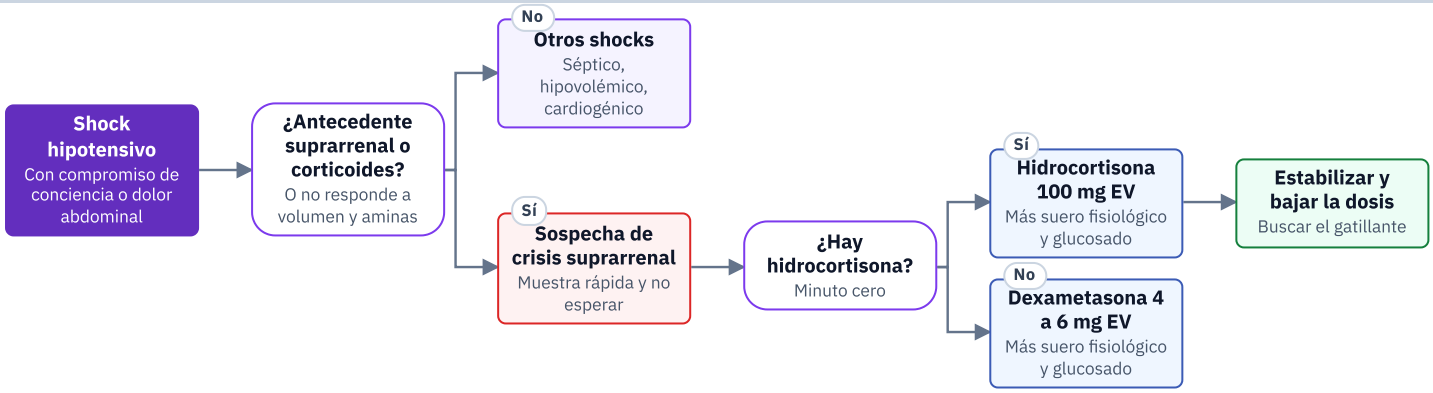


TABLA 7.13 · PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CRISIS SUPRARRENAL AGUDA EUNACOM

PRIORIDAD / TIEMPO	INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA INMEDIATA	FÁRMACO Y DOSIS RECOMENDADA	OBJETIVO FISIOLÓGICO CRÍTICO
Minuto 0 (Inmediato)	Bolo EV de Glucocorticoide de rescate	Hidrocortisona 100 mg EV directo	Restaurar reactividad vascular a catecolaminas
Minuto 5 - 60	Expansión agresiva de volumen intravascular	Suero Fisiológico 0.9% 1000 mL en la 1ra hora	Corregir shock distributivo e hiponatremia
Minuto 5 - 60	Reversión de la hipoglicemia aguda	Suero Glucosado al 10% 250-500 mL EV	Normalizar glicemia capilar > 100 mg/dL
Mantenimiento (24-48h)	Glucocorticoide parenteral continuo	Hidrocortisona 50 mg EV c/6h o 200 mg/24h BIC	Mantener soporte en fase de estrés metabólico
Transición Estable	Desescalamiento a vía oral	Hidrocortisona oral + Fludrocortisona (si Addison)	Retorno a dosis fisiológica de mantención

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Sospecha de crisis en shock	Muestra + hidrocortisona inmediata	Esperar el cortisol para tratar
Shock que no responde a volumen	Hidrocortisona 100 mg EV	Subir la noradrenalina o dar dopamina
Addison en fase aguda	Solo hidrocortisona a dosis altas	Agregar fludrocortisona

REGLA DE ORO **Shock refractario + antecedente** — Addison, corticoides o hiperplasia congénita

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **49–52** (págs. 22–23) · solucionario págs. 38–39.

Clase 7.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

7.14 Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria

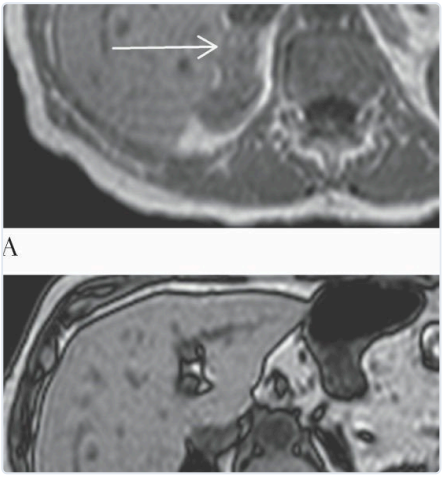
★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hipertensión arterial secundaria

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Hiperaldosteronismo Primario es la causa endocrinológica más frecuente de hipertensión arterial secundaria (**~10%** de hipertensos).
- **Debe sospecharse formalmente ante**: HTA resistente (**≥ 3 fármacos**), HTA en jóvenes (< **35-40 años**) o HTA asociada a hipokalemia.
- **El sello bioquímico distintivo es**: ALDOSTERONA ELEVADA CON RENINA PLASMÁTICA SUPRIMIDA.
- La prueba de tamizaje de primera elección es la Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con aldosterona > 15 ng/dL).
- La causa más frecuente es la Hiperplasia Suprarrenal Bilateral (**60-65%**), seguida del Adenoma Unilateral de Conn (**30-35%**).
- El Adenoma de Conn se trata de forma curativa mediante Suprarrenalectomía Laparoscópica Unilateral.



RM: ADENOMA SUPRARRENAL
CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 383

ALGORITMO · HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO: DE LA SOSPECHA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

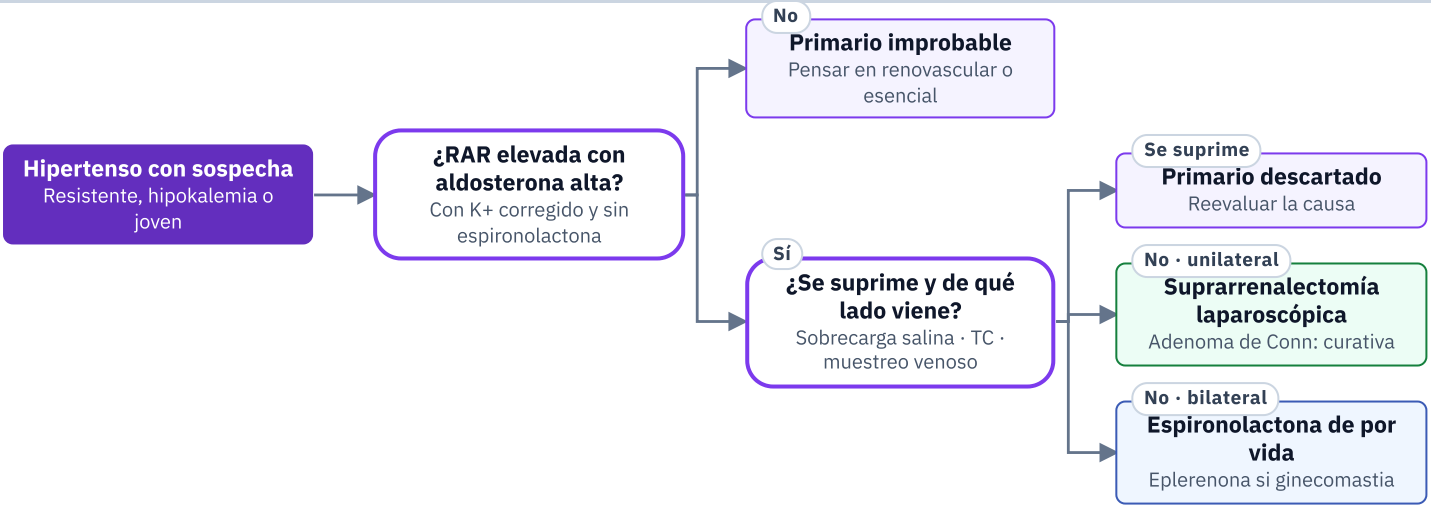


TABLA 7.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO VS SECUNDARIO EN EUNACOM

PARÁMETRO / CRITERIO	HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (CONN / HIPERPLASIA)	HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO (ESTENOSIS RENAL / RENINOMA)
Mecanismo Central	Producción autónoma suprarrenal independiente de renina	Hipoperfusión renal que activa masivamente el eje SRAA
Renina Plasmática (PRA)	SUPRIMIDA o indetectable (< 0.6 ng/mL/h)	FRANCAMENTE ELEVADA (> 5 ng/mL/h)
Aldosterona Plasmática	Elevada (> 15-20 ng/dL)	Elevada (estimulada por angiotensina II)
Relación Aldosterona / Renina	Muy Elevada (RAR > 20 a 30)	Baja o Normal (RAR < 10)
Causas Típicas	Adenoma de Conn (unilateral), Hiperplasia bilateral	Estenosis arteria renal, coartación aórtica, insuficiencia cardíaca
Tratamiento Inicial	Cirugía laparoscópica si Conn / Espironolactona	Angioplastia con stent renal / Manejo de la cardiopatía

REGLA DE ORO **Resistente, hipokalemia o joven** — Son los tres gatillos clásicos

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **53–54** (pág. 23) · solucionario pág. 39.

Clase 7.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

7.15 Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

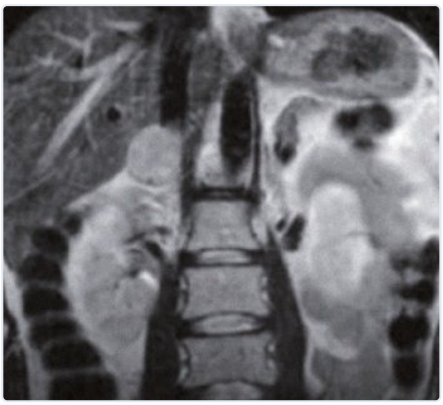
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Tumor suprarrenal · Incidentaloma suprarrenal

LO QUE TE PREGUNTAN

- El feocromocitoma se origina en las células cromafines de la médula suprarrenal secretoras de catecolaminas.
- **La tríada paroxística clásica altamente específica es**: CEFALEA pulsátil + DIAFORESIS profusa + PALPITACIONES taquicárdicas con hipertensión arterial.
- La prueba diagnóstica de tamizaje de primera elección con mayor sensibilidad (> **98%**) es la medición de METANEFRINAS libres plasmáticas o urinarias de **24 horas**.
- **Hasta un 35-40% de los casos se asocian a síndromes genéticos**: NEM 2A, NEM 2B (gen RET), Von Hippel-Lindau (VHL) y Neurofibromatosis 1 (NF1).
- **REGLA DE ORO DE PREPARACIÓN QUIRÚRGICA**: NUNCA administrar un betabloqueador antes de haber completado un bloqueo alfa-adrenérgico eficaz.



RM: MASA SUPRARRENAL
Manual AMIR Endocrinología, p. 59

ALGORITMO · FEOCROMOCITOMA: DE LA CRISIS AL PABELLÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

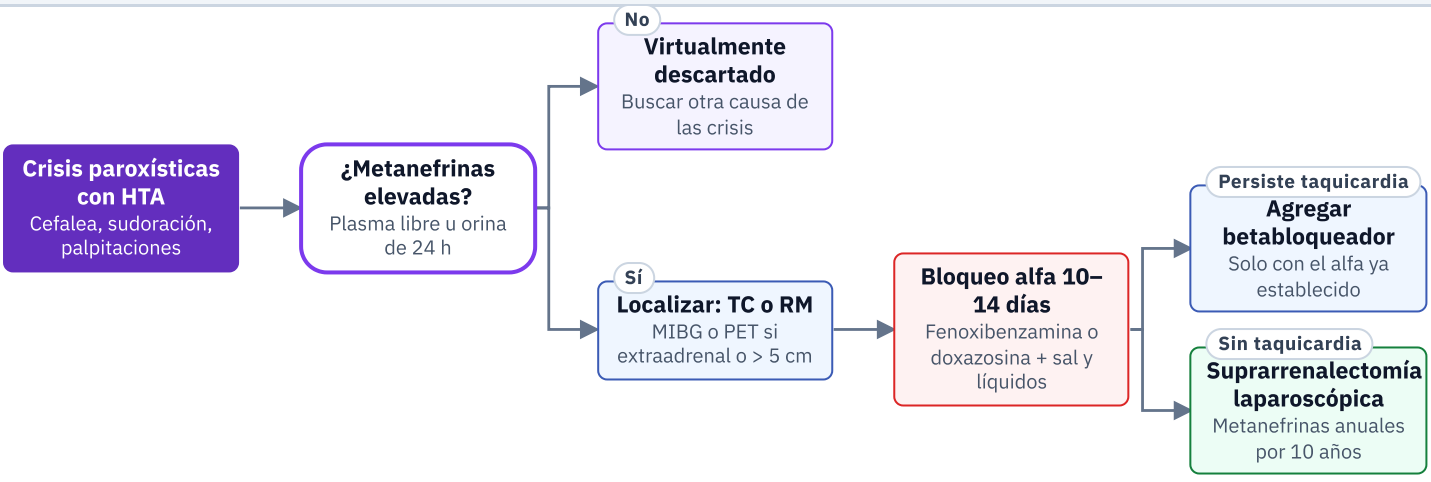


TABLA 7.15 · SÍNDROMES FAMILIARES ASOCIADOS A FEOCROMOCITOMA EN EUNACOM

SÍNDROME GENÉTICO	GEN / HERENCIA	TUMORES ASOCIADOS PRINCIPALES	CARACTERÍSTICAS DEL FEOCROMOCITOMA
NEM 2A (S. Sipple)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular de Tiroides (100%) + Hiperparatiroidismo 1° (20-30%)	Bilateral en > 50% de casos, benigno
NEM 2B (S. Gorlin)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular agresivo + Neuromas mucosos + Hábito marfanoide	Bilateral en > 50% de casos, muy precoz
Enfermedad de Von Hippel-Lindau	Gen VHL / Autosómica dominante	Hemangioblastomas de retina y SNC + Carcinoma de células claras renal	Frecuentemente bilateral o múltiple
Neurofibromatosis Tipo 1	Gen NF1 / Autosómica dominante	Manchas café con leche + Neurofibromas cutáneos + Nódulos de Lisch	Feocromocitoma en 1-5% de casos

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Crisis de cefalea, sudor y palpitaciones	Metanefrinas plasmáticas u orina 24 h	Pedir TC de entrada
Metanefrinas normales	Buscar otra causa	Seguir con imágenes
Feocromocitoma con taquicardia	Bloqueo alfa primero	Betabloqueador solo

REGLA DE ORO **Cefalea + sudor + palpitaciones** — Paroxísticas, con HTA

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Endocrinología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 7.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

MUY ALTA

1.03.1.020 **Hipercalcemias e hipocalcemias** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hipercalcemia aguda · PTH, calcemia · Hipercalcemia

LO QUE TE PREGUNTAN

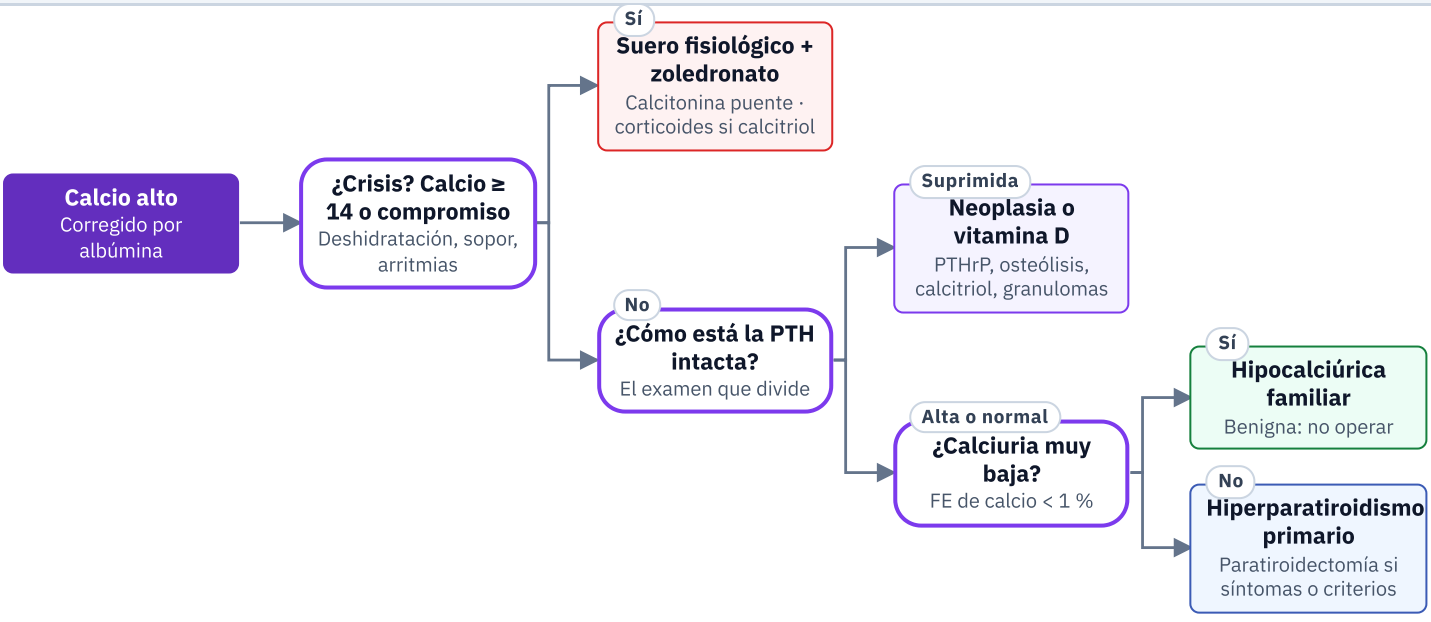
- El Hiperparatiroidismo Primario es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio; la Hipercalcemia Maligna lo es en el paciente hospitalizado.
- **REGLA OBLIGATORIA**: Siempre corregir el calcio por albúmina: Calcio Corregido = Calcio Medido + **0.8 ×** (4.0 - Albúmina).
- **La PTH Intacta (PTHi) divide el algoritmo**: PTH alta o normal-inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia (PTHrP o metástasis).
- El HPT 1° se debe en un **85%** a un Adenoma Paratiroideo único benigno.
- **La tríada bioquímica del HPT 1° es**: HIPERCALCEMIA + HIPOFOSFATEMIA + PTHi ELEVADA.
- La medida inicial de máxima urgencia ante una crisis hipercalcémica (> **14 mg/dL**) es la hidratación enérgica con Suero Fisiológico al **0.9%** (2 a 4 litros en **24h**).
- El Ácido Zoledrónico EV (bifosfonato) es el fármaco de elección para el control sostenido de la resorción ósea hipercalcémica.



OSTEÍTIS FIBROSA QUÍSTICA
Fundamentals of Skeletal Radiology (Helms), p. 15

ALGORITMO · HIPERCALCEMIA: DE LA CIFRA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **55–60, 62–65** (págs. 23–25) · solucionario págs. 39–41.

Clase 7.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 7.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO VS HIPERCALCEMIA MALIGNA VS HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA FAMILIAR

ENTIDAD CLÍNICA	CALCIO SÉRICO CORREGIDO	PTH INTACTA (PTHI)	FÓSFORO SÉRICO	CALCIURIA 24 HORAS	CAUSA / MECANISMO CENTRAL
Hiperparatiroidismo Primario	Elevado (leve a moderado)	Elevada o 'inapropiadamente normal'	Bajo (< 2.5 mg/dL, hipofosfatemia)	Normal o Elevada (> 200-400 mg/d)	Adenoma paratiroideo único (85%)
Hipercalcemia Maligna (PTHrP)	Muy Elevado (> 13-14 mg/dL)	SUPRIMIDA (< 5-10 pg/mL)	Bajo o Normal	Muy Elevada (> 400 mg/d)	Carcinoma epidermoide, mama, riñón
Hipercalcemia Maligna (Osteólisis)	Muy Elevado	SUPRIMIDA	Elevado o Normal	Muy Elevada	Mieloma múltiple, metástasis óseas
Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar (FHH)	Elevado leve (< 11.5 mg/dL)	Normal o discretamente elevada	Normal	MUY BAJA (< 100 mg/d, FE Ca < 1%)	Mutación inactivadora receptor CaSR (benigna, no operar)
Toxicidad por Vitamina D	Elevado	SUPRIMIDA	ELEVADO (aumenta absorción renal/int)	Elevada	Exceso de ingesta o granulomatosis (sarcoidosis)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Calcio "normal" con albúmina baja	Corregir por albúmina	Darlo por normal
Hipercalcemia, con o sin cáncer conocido	PTH intacta	Cintigrafía ósea o vitamina D
Crisis hipercalcémica	Suero fisiológico primero	Furosemida, zoledronato o calcitonina solos

REGLA DE ORO **Corregir por albúmina** — Ca + 0,8 × (4 – albúmina)

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La hipercalcemia es un trastorno hidroelectrolítico de alta relevancia en la medicina interna y en el examen EUNACOM. Más del 90% de todos los casos de hipercalcemia se deben a dos entidades clínicas fundamentales: Hiperparatiroidismo Primario (causa más frecuente en pacientes ambulatorios asintomáticos) e Hipercalcemia Maligna Asociada a Neoplasias (causa más común en pacientes hospitalizados con sintomatología florida). EUNACOM evalúa con máxima regularidad la fórmula de corrección del calcio por albúmina, el uso discriminativo de la PTH intacta para separar causas dependientes de independientes, el protocolo de hidratación agresiva con suero fisiológico y bifosfonatos endovenosos en la crisis aguda, y los criterios quirúrgicos de paratiroidectomía en pacientes asintomáticos.

TABLA 7.16.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO EN HIPERCALCEMIA AGUDA SEVERA

FÁRMACO / MEDIDA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	INICIO Y PICO DE ACCIÓN	ROL CLÍNICO / PRECAUCIÓN CRÍTICA
Suero Fisiológico al 0.9%	200-300 mL/h (2-4 L en 24h) EV	Inmediato (primeras horas)	Pilar 1 absoluto. Restaura volumen y promueve calciuresis
Ácido Zoledrónico	4 mg EV en 100 mL SF en 15 min	Inicio 48h, pico a los 4-7 días	Inhibe resorción osteoclástica. Ajustar si VFG < 30 mL/min
Calcitonina de Salmón	4-8 UI/kg SC o IM cada 12 horas	Inicio en 4-6 horas	Terapia puente rápida. Presenta taquifilaxia tras 48 horas
Prednisona / Hidrocortisona	Prednisona 40-60 mg/d VO o HC 100 mg EV c/8h	Inicio en 2-4 días	Elección en linfomas, mieloma o sarcoidosis (bloquea 1-alfa-OH)
Hemodiálisis con baño bajo en Ca	Sesión de diálisis con filtro sin calcio	Inmediato durante la terapia	Indicado en falla renal anúrica severa o refractariedad extrema

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **55–60, 62–65** (págs. 23–25) · solucionario págs. 39–41.

Clase 7.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

7.17 Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

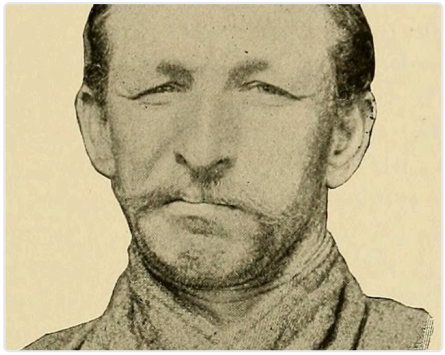
★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.020 Hipercalcemias e hipocalcemias — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Tetania

LO QUE TE PREGUNTAN

- La causa más frecuente de hipocalcemia aguda en el paciente hospitalizado es el Hipoparatiroidismo Postquirúrgico post-tiroidectomía total.
- El Signo de Trousseau (espasmo carpopedal al inflar el manguito de PA durante **3 minutos**) es más sensible y específico que el signo de Chvostek.
- La manifestación electrocardiográfica característica de la hipocalcemia es la PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT a expensas del segmento ST.
- **Tratamiento de rescate inmediato en hipocalcemia sintomática**: GLUCONATO DE CALCIO AL **10%** (1-2 ampollas EV lento en **10-20 minutos**).
- Se prefiere gluconato de calcio sobre cloruro de calcio porque este último produce necrosis tisular grave en caso de extravasación.



CHVOSTEK
Wikimedia Commons «Facial spasm (Chvostek's symptom).jpg», Public domain, Alfred Loomis & William Thompson

ALGORITMO · HIPOCALCEMIA: RESCATAR, REVISAR EL MAGNESIO Y MANTENER

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

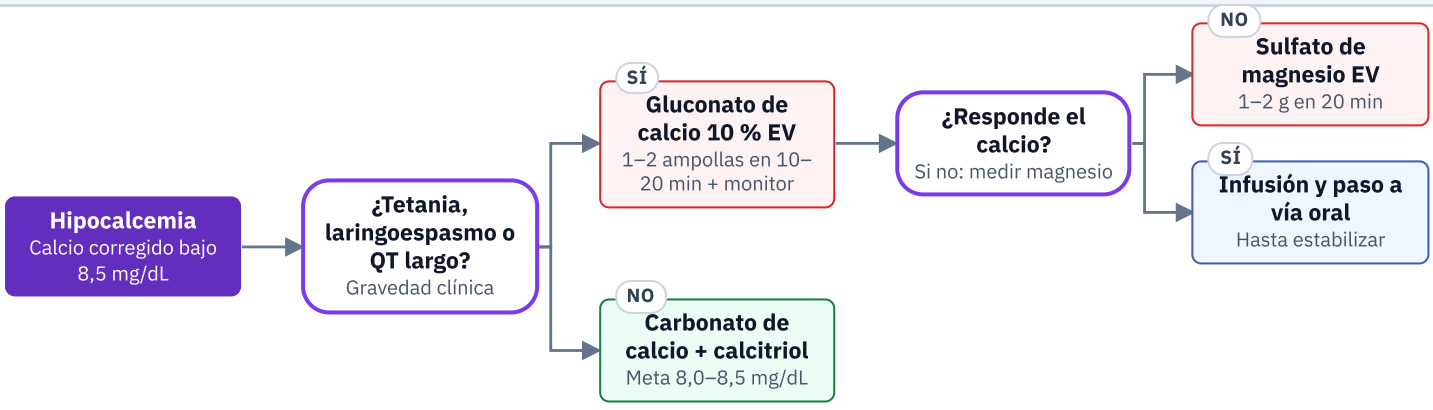


TABLA 7.17 · COMPARACIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA EN TRASTORNOS DEL CALCIO EN EUNACOM

PARÁMETRO	HIPOCALCEMIA AGUDA GRAVE	HIPOCALCEMIA CRÓNICA ESTABLE	HIPOCALCEMIA POR HIPOMAGNESEMIA
Presentación Típica	Parestesias, Trousseau +, Laringoespasmo	Asintomática, cataratas, calcificación ganglios basales	Refractaria a infusión repetida de calcio
Examen Físico Clave	Trousseau (+) en 94%, Chvostek (+)	Chvostek débil o negativo	Tetania + temblor + arritmias
Riesgo ECG	Prolongación del intervalo QT (Torsades)	QT limítrofe o normal	QT prolongado + arritmias ventriculares
Fármaco de Elección	Gluconato de Calcio 10% EV en bolo lento	Carbonato de Calcio oral + Calcitriol oral	Sulfato de Magnesio EV obligatorio previo
Precaución Crítica	Monitoreo cardíaco; evitar extravasación	Meta calcio 8.0-8.5 mg/dL (evitar hipercalciuria)	Medir siempre magnesio antes de considerar falla de calcio

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CLAVE	CONDUCTA
Aguda grave	Trousseau +, laringoespasmo, QT largo	Gluconato de calcio 10 % EV lento + monitor
Crónica estable	Asintomática, cataratas, calcificación de ganglios basales	Carbonato de calcio + calcitriol oral
Por hipomagnesemia	No responde al calcio repetido	Sulfato de magnesio EV primero

REGLA DE ORO **Parestesias tras tiroidectomía** — Hipoparatiroidismo hasta demostrar lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **61, 66–67** (págs. 24–25) · solucionario págs. 40–41.

Clase 7.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.03.1.018
1.07.1.015
Osteoporosis

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Densitometría ósea · Prevención de osteoporosis · Osteoporosis secundaria

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico densitométrico de osteoporosis según la OMS es un T-score ≤ -2.5 desviaciones estándar en columna lumbar o cadera.
- La presencia de una fractura por fragilidad en adulto mayor (cadera, vértebra) establece el diagnóstico clínico directo de OSTEOPOROSIS independientemente de la DEXA.
- El tratamiento de primera línea de elección son los Bifosfonatos (Alendronato oral **70 mg**/semana o Ácido Zoledrónico **5 mg** EV anual).
- **REGLA ESTRICTA DE ALENDRONATO**: Ingerir en ayunas estricto con un vaso lleno de agua de la llave y permanecer de pie o sentado **30-60 minutos** sin acostarse.

ALGORITMO · OSTEOPOROSIS: DIAGNOSTICAR Y ELEGIR EL TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

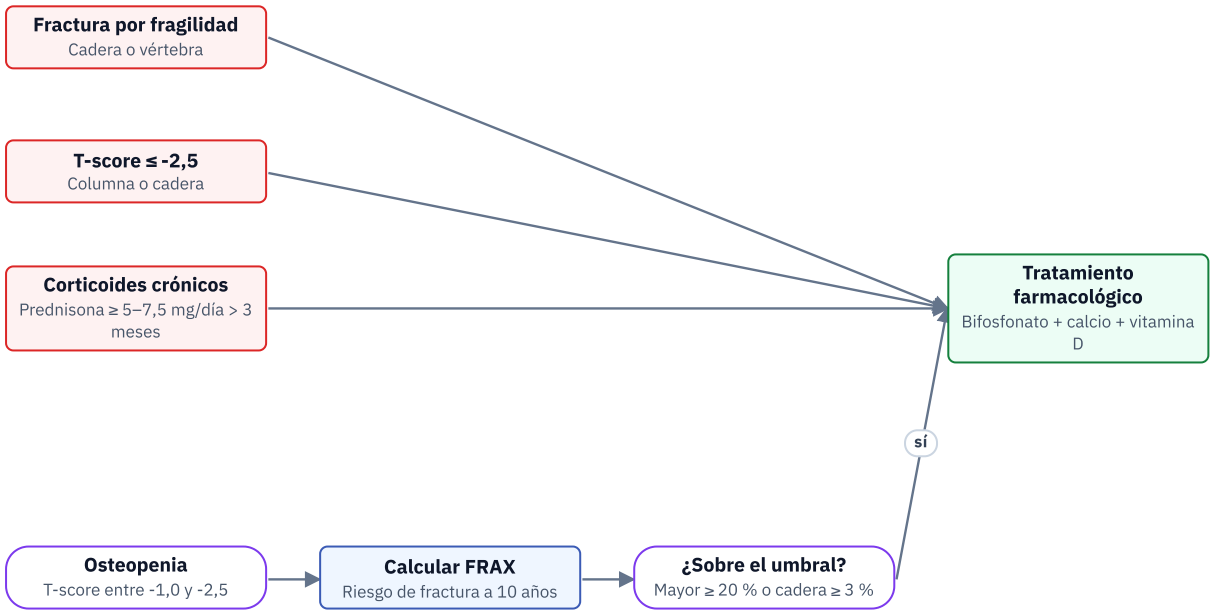


TABLA 7.18 · COMPARACIÓN DE TERAPIAS ANTIOSTEOPORÓTICAS EN EUNACOM

FÁRMACO / CLASE	VÍA Y POSOLOGÍA	MECANISMO DE ACCIÓN	VENTAJAS Y CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Alendronato (Bifosfonato)	70 mg VO semanal en ayuno	Antirresortivo (apoptosis osteoclasto)	Económico, alta eficacia. Exige ayuno y bipedestación 30 min
Ácido Zoledrónico (Bifosfonato)	5 mg EV anual en infusión 15 min	Antirresortivo de máxima potencia	100% adherencia. Evita toxicidad digestiva. Precaución si VFG < 35
Denosumab (Anticuerpo monoclonal)	60 mg SC semestral	Inhibe ligando RANK (RANKL)	Útil en falla renal moderada. Si se suspende: efecto rebote rápido
Teriparatida (Análogo PTH 1-34)	20 mcg SC diario (máx 24 meses)	OSTEOFORMADOR / Anabólico óseo	Elección en osteoporosis severa con múltiples fracturas vertebrales

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fractura de cadera tras caída a nivel, T-score -2,2	Bifosfonato + calcio + vitamina D	No tratar porque no llega a -2,5

REGLA DE ORO **T-score ≤ -2,5** — En columna o cadera: osteoporosis

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **68–70** (pág. 25) · solucionario pág. 42.

Clase 7.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

7.19 Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

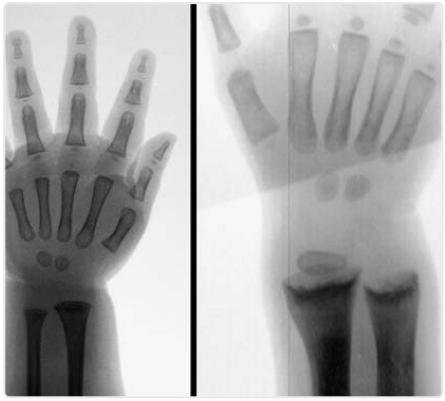
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

1.02.1.017 Síndromes carenciales de vitaminas y minerales — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Perfil bioquímico

LO QUE TE PREGUNTAN

- El examen de elección indiscutido para evaluar depósitos corporales de vitamina D es la 25-HIDROXIVITAMINA D sérica [25(OH)D].
- NUNCA se solicita calcitriol [1,25(OH)2D] para tamizaje ni diagnóstico de deficiencia, ya que puede estar normal o elevado por estímulo de la PTH.
- Deficiencia se define como 25(OH)D < 20 ng/mL; insuficiencia entre 20 y 29 ng/mL; suficiencia óptima **≥ 30 ng/mL**.
- La deficiencia severa y prolongada causa Osteomalacia en adultos y Raquitismo en niños (defecto de mineralización de la matriz osteoide).
- **El perfil analítico de la Osteomalacia es**: Calcio normal-bajo + Fósforo bajo + FOSFATASAS ALCALINAS ELEVADAS + PTH elevada.



RADIOGRAFÍA
Nelson 22.ª ed., p. 647

ALGORITMO · DÉFICIT DE VITAMINA D: MEDIR, CLASIFICAR Y REPONER

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

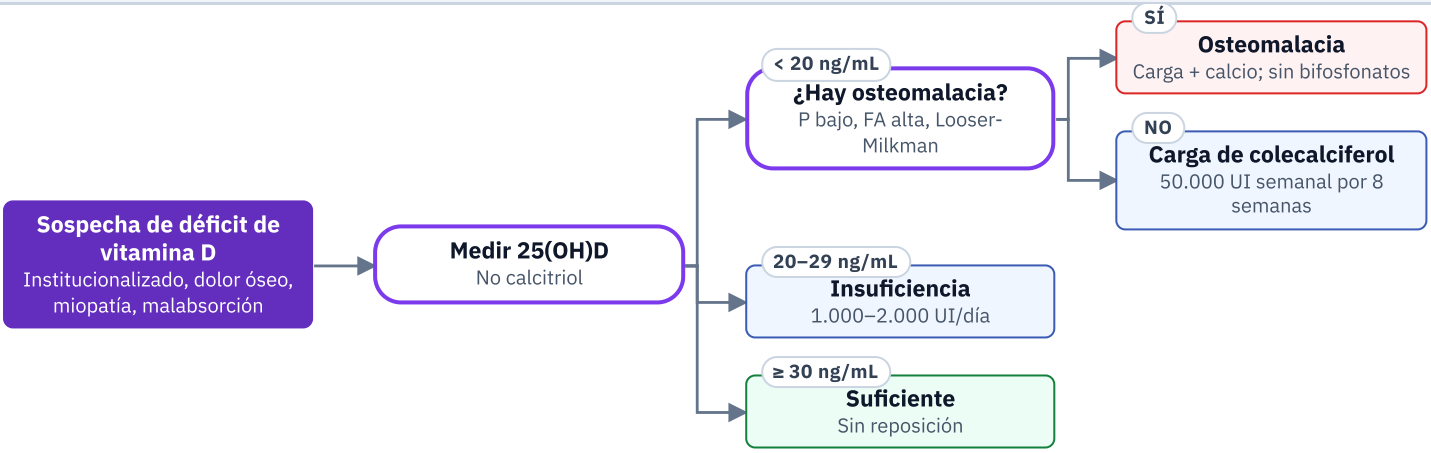


TABLA 7.19 · PERFIL BIOQUÍMICO COMPARATIVO EN ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS EN EUNACOM

ENFERMEDAD ÓSEA	CALCIO SÉRICO	FÓSFORO SÉRICO	FOSFATASA ALCALINA (FA)	PTH INTACTA	25(OH) VITAMINA D
Osteomalacia / Raquitismo	Normal-bajo o Bajo	BAJO (< 2.5 mg/dL)	ELEVADA (marcador clave)	ELEVADA (HPT 2°)	MUY BAJA (< 10-20 ng/mL)
Osteoporosis Primaria	Normal (8.5-10.5)	Normal (2.5-4.5)	Normal	Normal	Normal o Insuficiente
Enfermedad de Paget Ósea	Normal	Normal	MASIVAMENTE ELEVADA (> 5x)	Normal	Normal
Hiperparatiroidismo Primario	ELEVADO (> 10.5)	BAJO (< 2.5 mg/dL)	Normal o Levemente alta	ELEVADA o inapropiada	Variable

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Evaluar reservas de vitamina D	25(OH)D sérica	Pedir calcitriol
PTH alta con calcio normal o bajo	Medir 25(OH)D	Llamarlo hiperparatiroidismo primario
Dolor óseo, miopatía, FA alta, P bajo	Osteomalacia	Osteoporosis

REGLA DE ORO **Se mide la 25(OH)D** — Nunca el calcitriol para buscar déficit

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **71–72** (págs. 25–26) · solucionario págs. 42–43.

Clase 7.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

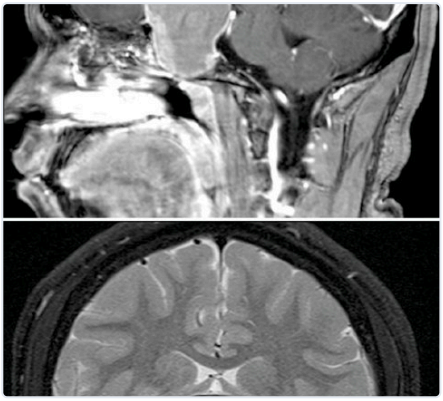
★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.013 **Tumores hipofisiarios** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Tumores de región sellar · Campo visual · Campo visual por confrontación

LO QUE TE PREGUNTAN

- El defecto campimétrico clásico de la compresión quiasmática por macroadenomas hipofisarios es la HEMIANOPSIA BITEMPORAL.
- **Toda masa selar exige tres estudios mandatorios**: RM de Silla Turca + Campimetría Computarizada + Perfil Hormonal Hipofisario completo.
- La Apoplejía Hipofisaria es una emergencia médica que debuta con cefalea en trueno, pérdida visual súbita, oftalmoplejía y colapso hemodinámico.
- La primera medida salvadora de vidas en la apoplejía hipofisaria es la administración inmediata de HIDROCORTISONA **100 mg** EV.
- La descompresión quirúrgica urgente en apoplejía está indicada si hay pérdida progresiva de agudeza visual o compromiso sensorial.



MACROADENOMA EN LA RM
Manual AMIR Endocrinología, p. 24

ALGORITMO · MASA SELAR: DE LA URGENCIA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

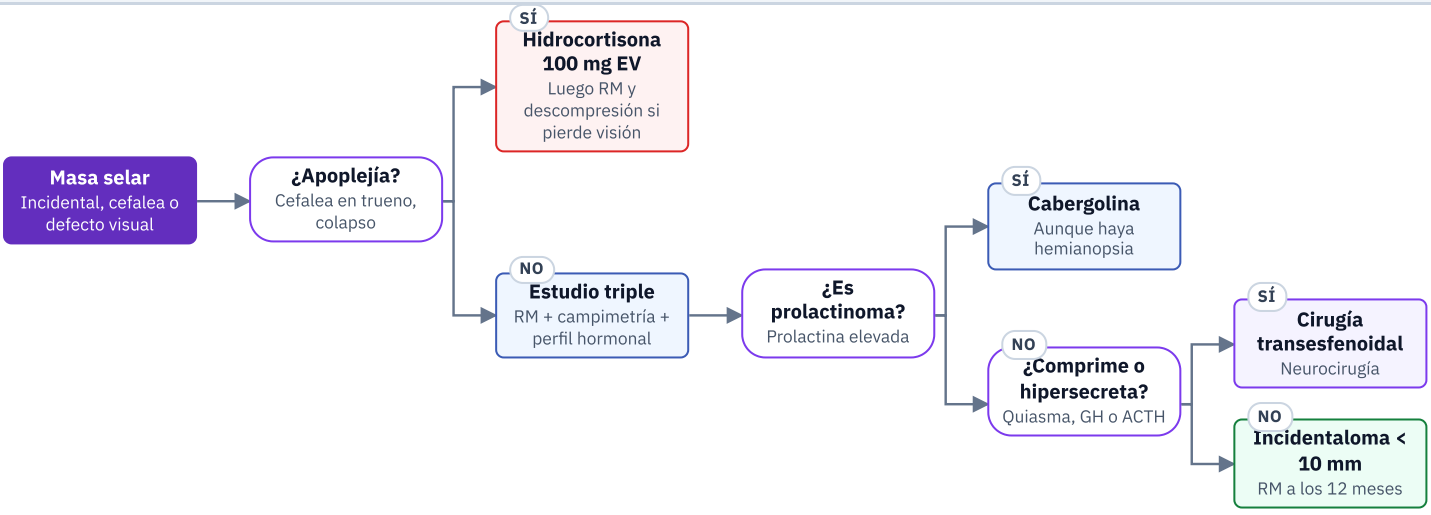


TABLA 7.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS EN LA REGIÓN SELAR EN EUNACOM

LESIÓN SELAR	EPIDEMIOLOGÍA TÍPICA	CARACTERÍSTICAS EN RESONANCIA / TC	CONDUCTA TERAPÉUTICA PRINCIPAL
Adenoma Hipofisario	Adultos 20-60 años, más común	Intraselar con o sin extensión supraselar, realce homogéneo	Cabergolina si prolactinoma; Cirugía si otros
Craneofaringioma	Bimodal (5-14 años y > 50 años)	Supraselar, quístico con calcificaciones gruesas en TC	Resección neuroquirúrgica +/- Radioterapia
Meningioma Selar	Mujeres de edad media	Base de implantación dural con 'cola dural' densa	Cirugía neuroquirúrgica si sintomático
Quiste de Rathke	Hallazgo incidental frecuente	Lesión quística intraselar bien delimitada sin realce	Observación salvo compresión visual
Apoplejía Hipofisaria	Crisis aguda sobre adenoma previo	Hiperintensidad T1 espontánea (sangrado agudo) selar	Hidrocortisona EV inmediata +/- Cirugía descompresiva

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hemianopsia bitemporal	Pensar en quiasma: macroadenoma	Buscar la lesión en el occipital

REGLA DE ORO **Hemianopsia bitemporal = quiasma** — Macroadenoma hasta demostrar lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **76–79** (págs. 26–27) · solucionario págs. 43–44.

Clase 7.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

7.21 Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.016 Hiperprolactinemia — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Tumores hipofisiarios · FSH, estradiol y prolactina

LO QUE TE PREGUNTAN

- La hiperprolactinemia fisiológica y farmacológica debe descartarse SIEMPRE antes de pensar en prolactinoma.
- **En toda mujer con amenorrea-galactorrea**: 1° Descartar embarazo (beta-hCG); 2° Medir TSH (el hipotiroidismo primario eleva prolactina vía TRH); 3° Revisar fármacos.
- **Los fármacos más comunes que inducen hiperprolactinemia son**: Risperidona, Haloperidol, Metoclopramida (antiemético) y Domperidona.
- Valores de prolactina > 100-200 ng/mL son prácticamente patognomónicos de prolactinoma.
- **REGLA DE ORO TERAPÉUTICA**: El tratamiento de primera línea de elección de TODOS los prolactinomas (micro y macroadenomas) es MÉDICO con CABERGOLINA.

ALGORITMO · HIPERPROLACTINEMIA: DESCARTAR, MEDIR, TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

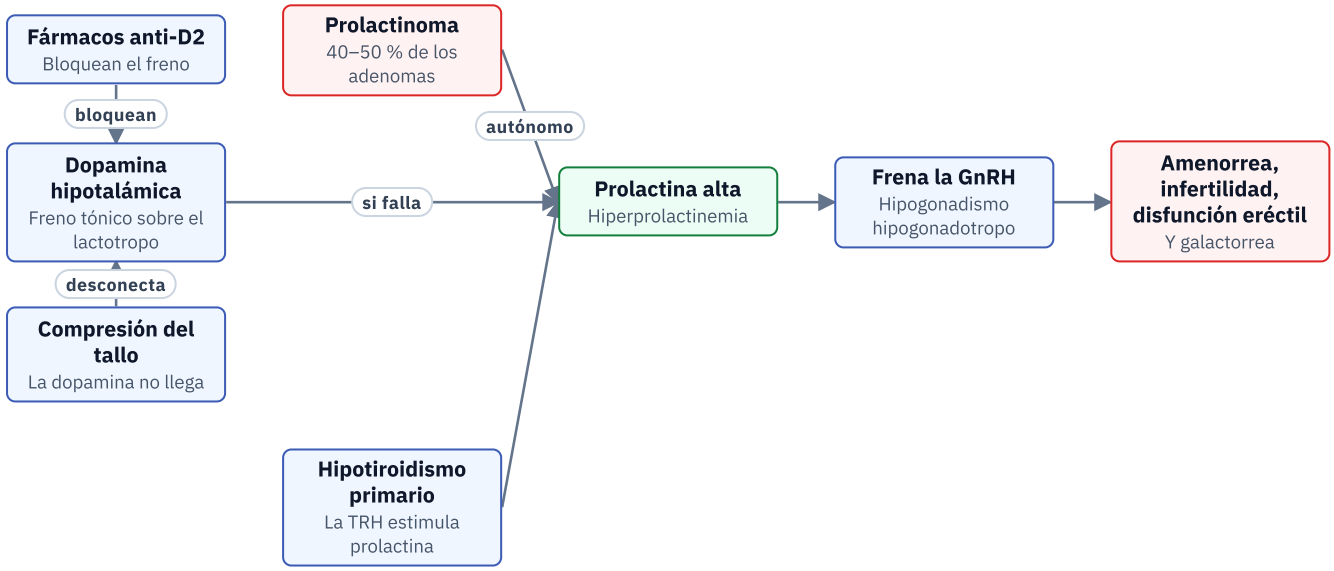


TABLA 7.21 · DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO SEGÚN NIVELES SÉRICOS DE PROLACTINA EN EUNACOM

RANGO DE PROLACTINA SÉRICA	ETIOLOGÍAS MÁS PROBABLES	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	CONDUCTA INICIAL RECOMENDADA
25 a 100 ng/mL	Fármacos (metoclopramida, risperidona), Hipotiroidismo 1°, Estrés, Microprolactinoma	Antagonismo D2 periférico, estímulo por TRH o microadenoma pequeño	Descartar fármacos, medir TSH y beta-hCG; repetir prolactina en reposo
100 a 200 ng/mL	Prolactinoma (frecuente microadenoma), Efecto compresión de tallo	Producción tumoral autónoma o pérdida de tono dopaminérgico	RM de Silla Turca con contraste gadolinio
> 200 a 250 ng/mL	Macroprolactinoma Hipofisario (casi 100% de especificidad)	Secreción masiva por masa adenomatosa ≥ 10 mm	Iniciar Cabergolina oral + Campimetría visual computarizada

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Amenorrea + galactorrea	Beta-hCG primero; luego prolactina y TSH	Resonancia de entrada
Usuaria de risperidona, prolactina 58	Causa farmacológica	Buscar un macroprolactinoma
Prolactina alta con TSH alta	Tratar el hipotiroidismo	Iniciar cabergolina

REGLA DE ORO **Beta-hCG, TSH y fármacos** — En ese orden

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **73, 80–82** (págs. 26–27) · solucionario págs. 43–45.

Clase 7.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

7.22 Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.013 Tumores hipofisiarios — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Acromegalia se debe en > **98%** a un Macroadenoma Hipofisario secretor de GH tras el cierre epifisario (si ocurre antes se llama Gigantismo).
- NUNCA solicitar GH basal aislada para tamizaje ni diagnóstico debido a su secreción pulsátil y fluctuante.
- La prueba de tamizaje de primera elección es la IGF-1 sérica (Somatomedina C), elevada para edad y sexo.
- La prueba confirmatoria de certeza es la SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (PTGO **75 g**): en personas normales suprime la GH a < **1.0 mcg**/L; en acromegalia no suprime.
- El tratamiento de primera línea de elección es la CIRUGÍA TRANSESFENOIDAL neuroquirúrgica.
- Si persiste enfermedad activa tras la cirugía, los fármacos de elección son los Análogos de la Somatostatina de acción prolongada (Octreótido / Lanreótido).



FENOTIPO ACROMEGÁLICO
Manual CTO Endocrinología 14.ª ed., p. 33

ALGORITMO · ACROMEGALIA: TAMIZAR, CONFIRMAR, OPERAR

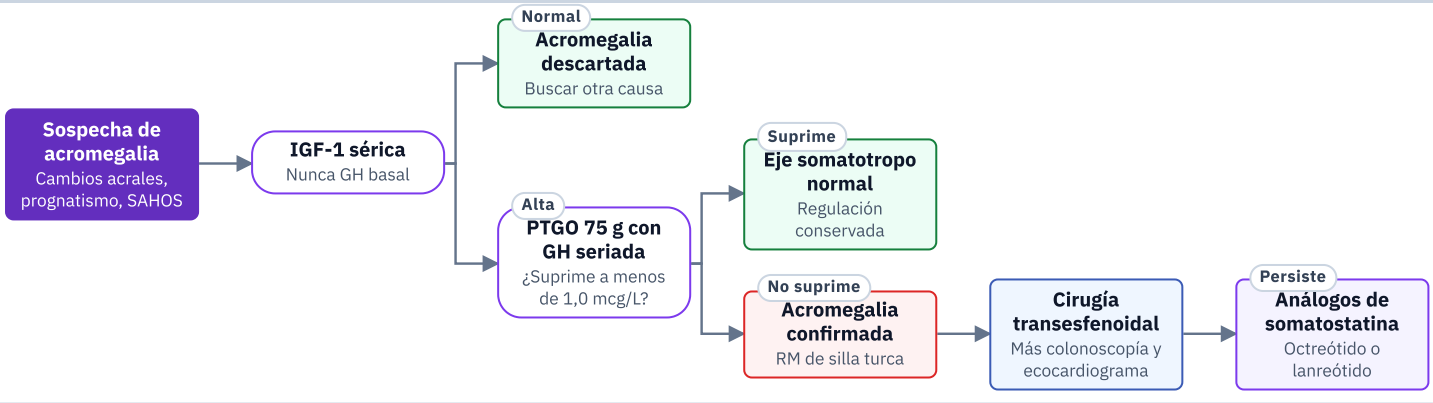


TABLA 7.22 · PROTOCOLO DIAGNÓSTICO ESCALONADO DE ACROMEGALIA EN EUNACOM

FASE DIAGNÓSTICA	EXAMEN INDICADO	RESULTADO PATOLÓGICO CONFIRMATORIO	SIGNIFICADO CLÍNICO / PRÓXIMO PASO
1. Tamizaje Inicial	IGF-1 (Somatomedina C) sérica	Elevada por sobre rango de referencia para edad y sexo	Alta sospecha de hipersecreción de GH; pasar a PTGO
2. Confirmación Dinámica	PTU 75g glucosa con GH seriada	Ausencia de supresión de GH (persiste ≥ 1.0 o 0.4 mcg/L)	DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO CONFIRMADO de acromegalia
3. Localización Anatómica	RM Silla Turca con gadolinio	Macroadenoma hipofisario (75%) o Microadenoma (25%)	Planificación de cirugía de resección transesfenoidal
4. Tamizaje de Complicaciones	Colonoscopía total + Ecocardiograma	Pólipos colónicos adenomatosos / Hipertrofia VI	Polipectomía preventiva y control de riesgo cardiovascular

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Sospecha de acromegalia	IGF-1 sérica	Medir GH basal
IGF-1 elevada	PTGO 75 g con GH seriada	Pedir RM y operar
GH no suprime tras glucosa	Acromegalia: RM de silla turca	Pensar que es normal

REGLA DE ORO **Nunca GH basal** — Tamizaje con IGF-1

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **83–84** (pág. 27) · solucionario pág. 45.

Clase 7.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

7.23 Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.014 Hipopituitarismo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hipogonadismo masculino

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Síndrome de Sheehan es la necrosis isquémica adenohipofisaria provocada por hemorragia obstétrica severa con hipotensión periparto.
- La manifestación más precoz y característica es el FRACASO COMPLETO DE LA LACTANCIA MATERNA (agalactia postparto inmediata).
- Cursa con amenorrea secundaria persistente, pérdida del vello axilar y pubiano, y síntomas de hipotiroidismo e hipocortisolismo.
- **El sello analítico del hipopituitarismo es**: HORMONAS PERIFÉRICAS BAJAS CON TROPINAS BAJAS O INAPROPIADAMENTE NORMALES.
- **REGLA DE SEGURIDAD VITAL**: SIEMPRE iniciar primero el reemplazo con Glucocorticoides (Hidrocortisona) antes de administrar Levotiroxina.
- Administrar levotiroxina antes que hidrocortisona en un panhipopituitarismo precipita una crisis suprarrenal aguda mortal por aclaramiento acelerado de cortisol.



SILLA TURCA VACÍA
Nelson 22.ª ed., Fig. 645.5A

ALGORITMO · HIPOPITUITARISMO: RECONOCER Y REEMPLAZAR EN ORDEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

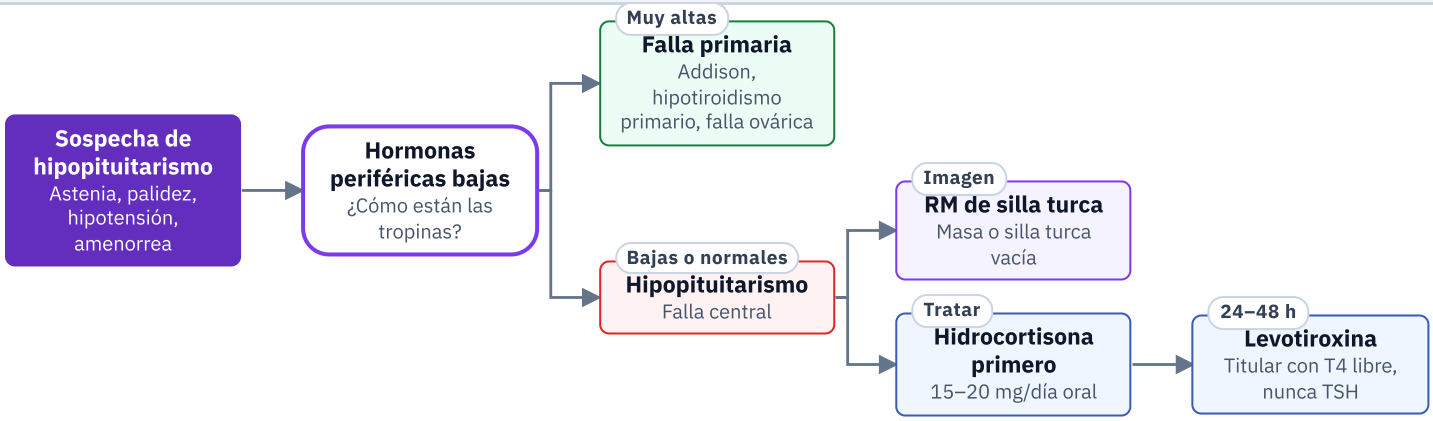


TABLA 7.23 · PERFIL BIOQUÍMICO COMPARATIVO: FALLA HORMONAL PRIMARIA VS HIPOPITUITARISMO CENTRAL EN EUNACOM

EJE ENDOCRINO	FALLA PRIMARIA (GLÁNDULA PERIFÉRICA)	HIPOPITUITARISMO (FALLA CENTRAL)	PARÁMETRO DE MONITOREO TERAPÉUTICO
Eje Tiroideo	T4L baja con TSH MUY ELEVADA (> 10 mIU/L)	T4L baja con TSH baja o normal inapropiada	Titular Levotiroxina con T4 LIBRE (la TSH no sirve)
Eje Suprarrenal	Cortisol bajo con ACTH MUY ELEVADA + Hiperpigmentación	Cortisol bajo con ACTH baja o normal + Piel pálida	Titular Hidrocortisona por clínica (peso, PA, energía)
Eje Gonadal	Estradiol bajo con FSH y LH MUY ELEVADAS	Estradiol bajo con FSH y LH bajas o normales	Alivio de síntomas climatéricos / fertilidad

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

EJE	FALLA PRIMARIA	HIPOPITUITARISMO	CÓMO SE CONTROLA
Reemplazo	Levotiroxina primero	Hidrocortisona primero	Error: crisis suprarrenal
Hombre	Testosterona baja, LH y FSH altas: Klinefelter	Testosterona baja, LH y FSH bajas: prolactina y RM	Testosterona si no desea fertilidad

REGLA DE ORO **Hemorragia posparto + agalactia** — Sheehan hasta demostrar lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **74, 85–87** (págs. 26–28) · solucionario págs. 43, 45–46.

Clase 7.23 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

7.24 Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.03.1.015 Diabetes insípida — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome de secreción inapropiada de ADH · Hipernatremia, poliuria

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Diabetes Insípida cursa con poliuria masiva hipotónica (osmolaridad urinaria < 300 mOsm/kg) e hipernatremia si se restringe el acceso al agua.
- El test de Desmopresina (DDAVP) diferencia la DI Central (la osmolaridad urinaria sube > **50-100%**) de la DI Nefrogénica (no responde a DDAVP).
- La causa farmacológica número uno de DI Nefrogénica es el CARBONATO DE LITIO.
- El SIADH cursa con HIPONATREMIA HIPOTÓNICA EUVOLÉMICA, con osmolaridad urinaria > 100 mOsm/kg y sodio urinario > **30 mEq/L**.
- La causa tumoral más frecuente de SIADH es el Carcinoma Pulmonar de Células Pequeñas (microcítico).
- El tratamiento inicial de elección del SIADH es la RESTRICCIÓN HÍDRICA (**500 a 1000 mL**/día).



MEN 2A: FEOCROMOCITOMA
Manual AMIR Endocrinología, p. 126

ALGORITMO · TRASTORNOS DE LA ADH: POLIURIA O HIPONATREMIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

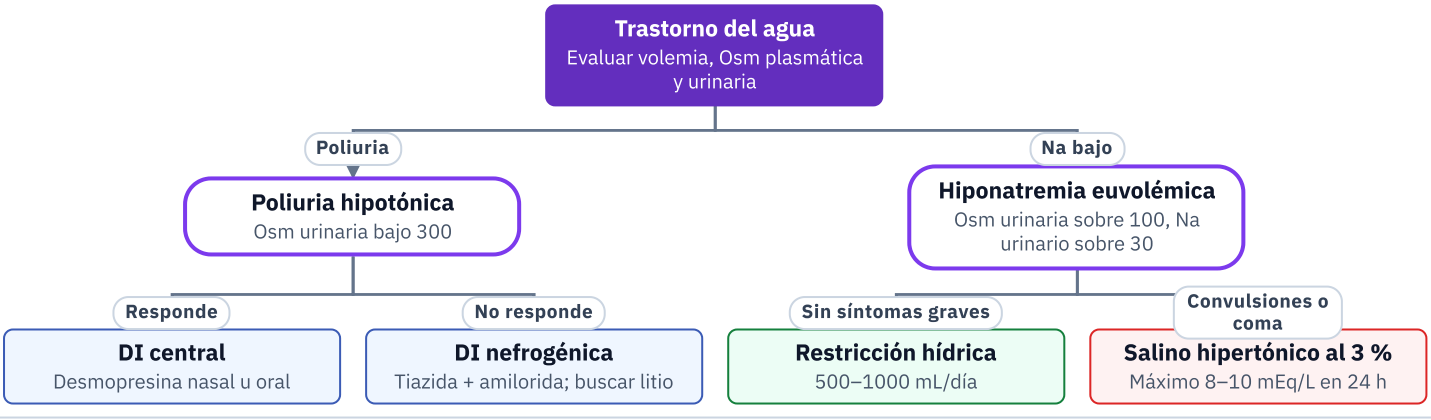


TABLA 7.24 · COMPARACIÓN DE SÍNDROMES DE NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN / NEM) EN EUNACOM

SÍNDROME	GEN / HERENCIA	TRÍADA TUMORAL CLÁSICA ('REGLA DE ORO')	REGLA QUIRÚRGICA EUNACOM
NEM 1 (S. Wermer)	Gen MEN1 (Menina) / Autosómica dominante	3 'P': Paratiroides (HPT 1°) + Páncreas (Gastrinoma/Insulinoma) + Pituitaria (Prolactinoma)	Paratiroidectomía subtotal (compromete 4 glándulas)
NEM 2A (S. Sipple)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular de Tiroides + Feocromocitoma + Hiperparatiroidismo 1°	Descartar y operar Feocromocitoma ANTES del tiroides
NEM 2B (S. Gorlin)	Protooncogén RET / Autosómica dominante	Carcinoma Medular + Feocromocitoma + Neuromas mucosos + Hábito marfanoide (Sin HPT)	Tiroidectomía profiláctica en el primer año de vida

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Poliuria e hipernatremia tras cirugía selar	DI central	SIADH
Usuario de litio con poliuria	DI nefrogénica	Polidipsia psicógena
DI que no responde a desmopresina	Tiazida + amilorida	Subir la desmopresina

REGLA DE ORO **Poliuria diluida ± hipernatremia** — Desmopresina distingue central de nefrogénica

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, preguntas **88–90** (pág. 28) · solucionario pág. 46.

Clase 7.24 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

7.25 Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.03.1.023 Ginecomastia — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ginecomastia es tejido glandular**: disco retroareolar **≥ 2 cm**, concéntrico al pezón. La seudoginecomastia es solo grasa, sin disco.
- **Tiene tres picos fisiológicos**: neonatal, puberal (Tanner 2-4, regresa en **1-2 años**) y adulto mayor.
- En el púber con examen testicular normal y sin fármacos no se piden exámenes: tranquilizar y controlar a los **6 meses**.
- La espironolactona es el fármaco causante más típico; se reemplaza por eplerenona.
- **El examen testicular es obligatorio**: un tumor de Leydig o un tumor germinal productor de hCG puede debutar con ginecomastia.

ALGORITMO · GINECOMASTIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

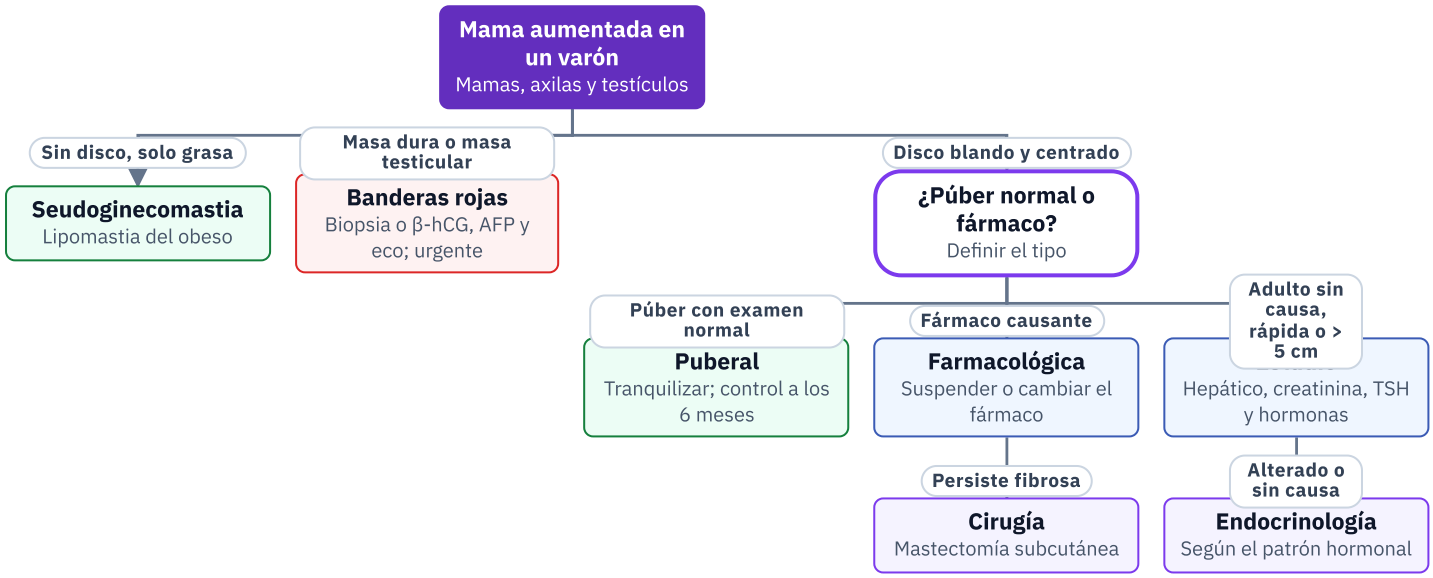


TABLA 7.25 · GINECOMASTIA: TIPO, DATO CLAVE Y CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL

TIPO	DATO CLÍNICO CLAVE	CONDUCTA INICIAL	CUÁNDO DERIVAR
Neonatal	Recién nacido, por estrógenos maternos	Tranquilizar; no exprimir	No requiere
Puberal	Tanner 2-4, bilateral o unilateral, sensible, testículos normales	Tranquilizar y control a los 6 meses	Persiste > 2 años, > 5 cm o testículos anormales
Farmacológica	Espironolactona, antiandrógenos, ketoconazol, anabolizantes	Suspender o cambiar el fármaco	Persiste o es fibrosa: cirugía
Por enfermedad sistémica	Cirrosis, ERC, hipertiroidismo	Tratar la causa	Según la enfermedad de base
Hipogonadismo	Testículos pequeños, libido baja; LH alta (primario) o baja (secundario)	Testosterona, LH, FSH; cariotipo o prolactina	Endocrinología
Tumoral (testículo, hCG)	Crecimiento rápido, masa testicular, β-hCG o estradiol altos	β-hCG, AFP y ecografía testicular	Urgente: urología/oncología
Cáncer de mama (diferencial)	Masa dura, excéntrica, fija, retracción, secreción sanguinolenta	Mamografía o ecografía y biopsia	Urgente: cirugía/oncología

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Recién nacido con mamas aumentadas	Tranquilizar; no exprimir	Pedir hormonas o ecografía
Púber: > 2 años, > 5 cm o testículos anormales	Estudiar y derivar	Seguir observando
Usuario de espironolactona	Cambiar a eplerenona	Biopsia, o suspender sin reemplazo

REGLA DE ORO **Disco ≥ 2 cm = glándula** — Sin disco: lipomastia

PRACTICA **Libro Gordo Endocrinología**, pregunta **75** (pág. 26) · solucionario pág. 43.

Clase 7.25 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 25 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS	
1.1 Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo	pág. 3
TSH alta: T**4L** baja o normal — Primario o subclínico	CORTE
1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina	pág. 4
Anciano asintomático con TSH < 10 — Observar	CORTE
TSH a las **6–8 semanas** — Meta 0,5 a 2,5	META
Subir **12,5–25 mcg** cada **6–8 semanas** — Según la TSH	DOSIS
1.3 Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas	pág. 6
Hiponatremia < 120–125 — No puede eliminar agua libre	CORTE
Temperatura central < **35 °C** — Frecuente entre 30 y **34 °C**	CORTE
1.4 Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito	pág. 7
2° y 3° trimestre: TSH < 3,0 — Algo más laxa	CORTE
TSH < 2,5 en el 1° trimestre — < 3,0 en el 2° y 3°	CORTE
Levotiroxina antes de los **15 días** — **10–15 mcg**/kg/día	DOSIS
1.5 Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)	pág. 8
VHS muy elevada — Sobre **60 a 100 mm**/h, con PCR alta	TIEMPO
Totalmente indolora — Anti-TPO positivos en **50 a 70 %**	CORTE
Prednisona si es refractario — **30 a 40 mg**/día, reducir en **4 a 6 semanas**	DOSIS
BLOQUE 02 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES	
7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos	pág. 9
TSH < 0,1 con T**4L** y T**3L** normales — Tratar si hay riesgo	CORTE
Leve: selenio por **6 meses** — **100 µg** cada **12 horas**	DOSIS
7.7 Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía	pág. 11
Bocio mayor a **80 g** — Bocio masivo	DOSIS
50 a 100 mg cada **8 horas** — Vida media corta	DOSIS
7.8 Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas	pág. 12
Paracetamol **1 g** cada **6 horas** — Oral o endovenoso	DOSIS
Carga de **500 a 1000 mg** — Luego **200 a 250 mg** cada **4 horas**	DOSIS
7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF	pág. 14
Nódulos < **1.0 cm** no se puncionan rutinariamente.	CORTE
Menor de **1 cm** sin riesgo: vigilar — Aunque sea TR5	CORTE
Solo **5–10 %** son malignos — Sobre todo carcinoma papilar	CORTE
7.10 Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico	pág. 16
25 % hereditario — NEM 2A o 2B por mutación RET	CORTE
Mayor de **65–70 años** — Masa pétrea, fija, crece en semanas	TIEMPO
BLOQUE 03 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA	
7.11 Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico	pág. 17
Masa mayor de **4–6 cm** — Heterogénea, invasora	CORTE
Dexametasona **1 mg** a las **23 h** — Cortisol plasmático a las **8 h**	DOSIS
Normal: menor de **1,8 mcg**/dL — Si no suprime: hipercortisolismo	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
7.12 Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria	pág. 18
Fludrocortisona **0,05–0,1 mg**/día — Una toma matinal	DOSIS
Alternativa: prednisona **3,75–5 mg** — Una toma matinal	DOSIS
7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario	pág. 19
Cotrimoxazol contra Pneumocystis — **≥ 20 mg/día** > **4 semanas** + otro inmunosupresor	DOSIS
Hiponatremia — Sodio bajo **130 mEq/L**	CORTE
Vuelve bajo **50 mg**/día de HC — **0,05 a 0,1 mg**/día oral	DOSIS
7.14 Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria	pág. 20
HTA en el joven — Inicio antes de los **35 a 40 años**	CORTE
Relación Aldosterona / Renina · Muy Elevada (RAR > 20 a 30) · Baja o Normal (RAR < 10)	CORTE
Renina Plasmática (PRA) · SUPRIMIDA o indetectable (< 0.6 ng/mL/h) · FRANCAMENTE ELEVADA (> 5 ng/mL/h)	DOSIS
7.15 Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio	pág. 21
O doxazosina — Alfa-1 selectivo, **2 a 16 mg**/día	DOSIS
Fenoxibenzamina — **10 mg** c/**12 h** hasta **80–100 mg**/día	DOSIS
BLOQUE 04 · BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO	
7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico	pág. 22
Menor de **50 años** — O calcio > **1 mg/dL** sobre el límite	DOSIS
Riñón: VFG < 60 — Calciuria > **400 mg**/día o litiasis en imagen	DOSIS
40 % unido a albúmina — **10 %** unido a aniones	CORTE
7.17 Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia	pág. 24
Carbonato de calcio + calcitriol — Meta **8,0–8,5 mg/dL**	DOSIS
Calcitriol **0,25 a 1,0 mcg**/día — La 1,25-dihidroxivitamina D	DOSIS
Carbonato de calcio — **1 a 3 g**/día de calcio elemental, repartido	DOSIS
7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento	pág. 25
Osteopenia: decide el FRAX — Mayor **≥ 20 %** o cadera **≥ 3 %**	CORTE
Vitamina D3 **800–2000 UI**/día — Colecalciferol	DOSIS
7.19 Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo	pág. 26
Deficiencia: < 20 ng/mL — Equivale a 50 nmol/L	DOSIS
Colecalciferol **1.000–2.000 UI**/día — Suplementación diaria	DOSIS
BLOQUE 05 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN	
7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria	pág. 27
No funcionante < **10 mm**, asintomático — Sin cirugía: RM a los **12 meses**	CORTE
Frente al paciente, a **50 cm** o 1 m — Ojos a la misma altura	CORTE
Prolactinoma **40 %**, no funcionante **30–35 %** — Somatotropo **15 %**, corticotropo **10 %**	CORTE
7.21 Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica	pág. 28
Valores de prolactina > 100-200 ng/mL son prácticamente patognomónicos de prolactinoma.	DOSIS
Agonista D2 de acción prolongada — **0,5 mg** VO **1–2 veces** por semana	DOSIS
Galactorrea en **50–80 %** — Espontánea o a la expresión	CORTE
7.22 Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo	pág. 29
Confirma la PTGO **75 g** — GH que no baja de **1,0 mcg**/L	DOSIS
Actúan sobre el receptor SSTR2 — Suprimen la GH en más del **60–70 %**	CORTE
Análogos de somatostatina — Octreótido LAR **20–30 mg** IM o lanreótido **120 mg** SC, mensual	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
7.23 Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo	pág. 30
Testosterona, hematocrito y APE — Hematocrito sobre **54 %**: reducir o suspender	CORTE
7.24 Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)	pág. 31
Máximo **8–10 mEq/L** en **24 h** — Evita la mielinólisis pontina	TIEMPO
Más de **3 a 5 L**/día — Hasta **15–20 L**, con polidipsia y nicturia	TIEMPO
7.25 Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica	pág. 32
Disco **≥ 2 cm** = glándula — Sin disco: lipomastia	CORTE
Cirugía — Fibrosa > **1-2 años** o impacto psicológico	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.5 Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)		pág. 8
De Quervain · Antiinflamatorio	**Prednisona si es refractario**	**30 a 40 mg**/día, reducir en **4 a 6 semanas**
De Quervain · Antiinflamatorio	**Propranolol para los síntomas**	Palpitaciones y temblor de la fase tóxica
Litio · Se pregunta	**Agregar levotiroxina**	Hasta normalizar la TSH
7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos		pág. 9
Radioyodo y cirugía · Radioyodo	**Prednisona profiláctica si se usa**	
Clínico	**Leve: tiamazol 10 a 15 mg + propranolol**	Control en **4 semanas**
Clínico	**Severo: tiamazol 30 a 40 mg**	Betabloqueo enérgico; anticoagular si hay FA
7.8 Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas		pág. 12
Betabloqueo y propiltiouracilo · Propranolol	**Broncoespasmo severo: esmolol o diltiazem**	Si el no selectivo está contraindicado
Betabloqueo y propiltiouracilo · Propiltiouracilo	**Preferido sobre el tiamazol**	También bloquea la conversión de T4 a T3
Hidrocortisona · Dosis	**Hidrocortisona 100 mg EV cada 8 horas**	O dexametasona **2 mg** EV cada **6 horas**
Control de la fiebre	**Paracetamol 1 g cada 6 horas**	Oral o endovenoso
7.11 Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico		pág. 17
Cada origen tiene su cirugía · Terapia médica	**Ketoconazol, metirapona, osilodrostat**	Bloquean la síntesis de cortisol
7.12 Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria		pág. 18
Reemplazar lo que falta · Glucocorticoide	**Hidrocortisona 15–25 mg/día**	En 2 o 3 tomas: 10 · 5 · **2,5 mg**
Reemplazar lo que falta · Glucocorticoide	**Alternativa: prednisona 3,75–5 mg**	Una toma matinal
7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario		pág. 19
¿Qué precipita la crisis? · Errores con los corticoides	**Suspensión brusca del corticoide**	Eje frenado por uso prolongado
¿Por qué hidrocortisona y no otro? · Hidrocortisona	**Efecto glucocorticoide y mineralocorticoide**	A dosis altas hace ambos trabajos
¿Por qué hidrocortisona y no otro? · Hidrocortisona	**El cortisol sobrante activa el receptor mineralocorticoide**	
Qué corrige cada medida · Hiperkalemia	**Hidrocortisona + suero salino**	Riesgo: arritmia ventricular
7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento		pág. 25
La causa más frecuente	**Glucocorticoides**	El fármaco más frecuente
7.21 Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica		pág. 28
La regla del descarte previo · Muy frecuentes en APS	**Metoclopramida, domperidona**	También ISRS, tricíclicos, verapamilo, opiáceos
7.22 Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo		pág. 29
Este adenoma sí se opera · Terapia médica coadyuvante	**Análogos de somatostatina**	Octreótido LAR **20–30 mg** IM o lanreótido **120 mg** SC, mensual
7.23 Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo		pág. 30
Testosterona · Primero la causa	**Opioides, anabolizantes, peso, cabergolina**	
7.25 Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica		pág. 32
El fármaco · Fármacos y drogas	**Espironolactona: la más típica**	Bloquea el receptor androgénico
El fármaco · Fármacos y drogas	**Ketoconazol, cimetidina, antiandrógenos**	Análogos de GnRH, finasterida, dutasterida
El fármaco · Fármacos y drogas	**Antipsicóticos y metoclopramida**	Por hiperprolactinemia

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
7.25 Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica (cont.)		pág. 32
El fármaco · Fármacos y drogas	**Y opioides**	

GES de Endocrinología & Metabolismo

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 35): Hipotiroidismo en Personas de 15 años y más**

Tema **1.1** · Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo
1.03.4.003 · 1.03.4.004
pág. **3**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 35): Hipotiroidismo en Personas de 15 años y más**

Tema **1.2** · Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina
1.03.1.002 · 1.03.4.003 · 1.03.4.005
pág. **4**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Hipotiroidismo Congénito (Tamizaje Universal Neonatal)**

Tema **1.4** · Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito
1.03.1.002 · 2.01.1.075 · 2.01.4.024
pág. **7**

GES **Sospecha fundada de cáncer de tiroides (Bethesda IV, V o VI) tiene acceso garantizado por GES Cáncer en personas de 15 años y más**

Tema **7.9** · Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF
1.03.1.021 · 1.03.4.001 · 1.03.1.001
pág. **14**

GES **GES N° 33 (Cáncer en personas de 15 años y más): Acceso a diagnóstico en 40 días, etapificación en 30 días y cirugía en 30 días post-indicación**

Tema **7.10** · Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico
1.03.1.004 · 4.01.1.033
pág. **16**

Sin garantía GES específica (20 temas): 1.3 · 1.5 · 7.6 · 7.7 · 7.8 · 7.11 · 7.12 · 7.13 · 7.14 · 7.15 · 7.16 · 7.17 · 7.18 · 7.19 · 7.20 · 7.21 · 7.22 · 7.23 · 7.24 · 7.25. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **7.16** Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico — 22
- ★★★ **7.9** Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF — 14
- ★★★ **7.17** Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia — 24
- ★★★ **1.4** Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito — 7
- ★★★ **1.2** Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina — 4

Practica: Libro Gordo Endocrinología, preguntas 7–10, 16–17, 33–36, 55–67.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **7.14** Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria — 20
- ★★★ **7.20** Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria — 27
- ★★★ **7.13** Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario — 19
- ★★★ **7.22** Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo — 29

Practica: Libro Gordo Endocrinología, preguntas 49–54, 76–79, 83–84.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **7.11** Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico — 17
- ★★☆ **7.15** Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio — 21
- ★★☆ **7.23** Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo — 30
- ★★☆ **1.5** Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) — 8

Practica: Libro Gordo Endocrinología, preguntas 18, 38–43, 74, 85–87.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **7.21** Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica — 28
- ★★☆ **7.24** Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) — 31
- ★★☆ **7.6** Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos — 9
- ★★☆ **7.7** Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía — 11

Practica: Libro Gordo Endocrinología, preguntas 19–27, 73, 80–82, 88–90.

DÍA 5

4 temas · ★

- ★☆☆ **1.3** Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas — 6
- ★☆☆ **7.19** Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo — 26
- ★☆☆ **7.12** Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria — 18
- ★☆☆ **1.1** Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo — 3

Practica: Libro Gordo Endocrinología, preguntas 1–6, 11–15, 44–48, 71–72.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **7.10** Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico — 16
- ★☆☆ **7.18** Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento — 25
- ★☆☆ **7.25** Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica — 32
- ★☆☆ **7.8** Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas — 12

Practica: Libro Gordo Endocrinología, preguntas 28–32, 68–70, 75.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 33
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.2 · 1.4 · 7.9 · 7.13 · 7.14 · 7.16 · 7.17 · 7.20 · 7.22
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Endocrinología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

16 7.16. Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico 22
15 7.9. Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF GES 14
14 7.17. Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia 24
11 1.4. Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito GES 7
9 1.2. Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina GES 4
9 7.14. Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria 20
8 7.20. Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria 27
7 7.13. Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario 19
7 7.22. Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo 29

★★ Prioridad media · 8 temas

6 7.11. Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico 17
6 7.15. Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio 21
6 7.23. Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo 30
5 1.5. Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) 8
5 7.21. Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica 28
5 7.24. Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) 31
4 7.6. Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos 9
4 7.7. Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía 11

★ Prioridad baja · 8 temas

3 1.3. Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas 6
3 7.19. Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo 26
2 7.12. Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria 18
1 1.1. Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo GES 3
1 7.10. Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico GES 16
1 7.18. Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento 25
1 7.25. Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica 32
0 7.8. Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas 12